

אסדרת מערך התמריצים במכרז הסיעוד

תוכן עניינים

01	רקע לפרויקט
02	מיפוי מצב קיים
03	מקרי בוחן מישראל
04	סקירה בינלאומית
05	סקירת ספרות
06	סיכום תובנות עיקריות
07	הצעה למודל להערכת תמריצים בשלב הבא

רקע לפרויקט



החלטת הממשלה לוותה בהקמת וועדה בין-משרדית. מטרות הוועדה היו:



הגדרת תפקידים

גיבוש הגדרות תפקידים מחודשות למטפלים, כולל מסלולי הכשרה וקידום



הכשרה

גיבוש תפיסת הכשרה וקביעת סטנדרט רצוי להתמקצעות



מודל יישום והטמעה

גיבוש מודל לתוכנית יישום והטמעה, כולל הצבת יעדים

המטפלים הישראלים בזקנים

טיוטת המלצות הוועדה הבין-משרדית, אוגוסט 2021

החלטת הממשלה 43 - "מפת דרכים לענף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים" **באה לקדם שינויים מהותיים בענף המטפלים בזקנים**, לאור פערים גדלים והולכים בין איכות הטיפול והיצע המטפלים לבין צרכיהם המורכבים והגוברים של הזקנים.

במסגרת החלטת הממשלה התקבלו החלטות ליישום אשר מטרותיהן העיקריות הן:

1. מעבר לטיפול מותאם להזדקנות מיטבית, **למניעת הידרדרות ולשיקום**
2. **שיפור איכות הטיפול** שהמטפלים מעניקים לזקנים סיעודיים
3. הגדלת היצע המטפלים
4. **הגדלת הפריון של המטפלים**

טיוטת המלצות הוועדה*



הקמת מערך תמיכה למטפלים

מערך תמיכה למטפלים במתכונת קבוצות תמיכה, כאשר ההשתתפות בקבוצת התמיכה תתוגמל בשכר



תמריצי שכר למטפלים

השתתפות בהכשרות תיחשב כעבודה ותתוגמל בשכר, תיתכן עלייה בשכר ע"פ דרגת המטפל



פיתוח הכשרות, וקביעת סטנדרטים לגופי הכשרה

פיתוח קורסים להכשרה תואמת דרגה



הגדרה חדשה לתפקיד המטפל ודרגות קידום

אופק תעסוקתי, הרחבת תחומי אחריות, והכרה במטפל כשותף במערך המקצועי



גיבוש תמריצים לשינוי המערכת לדוחקת תלות

שינוי במבנה התמריצים במטרה לעודד טיפול דוחק תלות והתמקצעות של כוח האדם



פיתוח מענים מותאמים לבני משפחה מטפלים

הנגשת מידע לבני המשפחה והפנייה שלהם לשירותים המיועדים עבורם



הקמת מערך פיקוח ובקרה

חיוב נותני השירות להליך מדידה פנימי יחד עם הקמת מערך מדידה ובקרה חיצוני



פיתוח מנגנונים לשיתוף מידע

שילוב מידע מבטל"א למטפל לאחר קביעת הזכאות, וקיום הערכת מצב המטופל פעם בשנה לטיוב הטיפול

* השקף מכיל המלצות נבחרות מדו"ח הוועדה

רקע לפרויקט

המדריך לרכש חברתי – ספטמבר 2016

המדריך כולל את המלצות הצוות הממשלתי לטיוב האספקה של שירותים חברתיים במיקור חוץ, שגובשו בתהליך שיתוף בין – מגזרי במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

המדריך מבטא, בהתאם להחלטת הממשלה, אמות מידה לשירות חברתי ואיכותו, הגדרת תהליך העבודה, הגברת התחרות טרם תקופת ההתקשרות ובמהלכה והלימה בין תוכן ההתקשרות לבין תוכן הבקרה והפיקוח.

☆☆☆ הגדרת סטנדרטים ומדדים באופן שיביא לשירות מצוין

- סטנדרטים להבטחת בטיחותו וכבודו של מקבל השירות – בטחון קיומי
- סטנדרטים להצלחת השירות – תיאוריית השינוי
- מדדי תוצאה, תפוקה, תשומה

הגדרת היישום למדדים

- שיח עם מפעילי השירות
- תגמול וקנס
- תשלום
- בחירת מפעילי שירותים



המודל הלוגי

של המדריך לרכש חברתי

המדריך לרכש חברתי מעודד בחינה של השרות באמצעות תיאוריית השינוי. תיאוריית השינוי עצמה מתארת את השינוי הרצוי, שצפוי להתרחש עקב התערבות ופעולות מסוימות. במסגרת העבודה בחנו את מערכי התמריצים הנוכחיים במכרז הסיעוד בין היתר על פי המודל הלוגי שמציב המדריך.

המודל הלוגי מציע חלוקה ברורה של השינוי אשר ברצוננו לעשות לתשומות, תפוקות ותוצאות. ליבת המודל עוסקת בשלושת המרכיבים (תשומות, תפוקות, תוצאות), בקשרים וכיצד הם משפיעים האחד על השני, כל זאת בראיית השינוי הרצוי.



מטרת הפרויקט

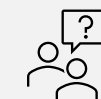
רקע



לגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי זכאי תושב ישראלי מעל גיל הפרישה שנמצא כי הוא זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום, שסכום הכנסותיו לא עובר את הקבוע בחוק ושאינו מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי. במסגרת הזכאות, זכאי הקשיש לגמלה כספית, שעות טיפול בביתו המסופקות על ידי חברת סיעוד ו/או שירותים נוספים.



צורך



כיום, אין מדיניות ממשלתית המקבלת ביטוי אופרטיבי ששמה במרכז את הזקן ומטרתה לדחוק עד כמה שאפשר את תלותו בזולת. זאת ועוד, בקרב הגופים האחראים על הטיפול הסיעודי בקהילה, לא קיים אף גוף אשר תמריצו הכלכלי לשמר את רמת התפקוד של הקשיש.



מטרה



מטרת הפרויקט היא לבחון את המידה שבה מבנה התמריצים הקיים במרכז הסיעוד בקהילה מקדם תכליות של מניעת הידרדרות, שיקום והזדקנות בריאה.



ניתוח מעמיק לחלופות נבחרות

בחינת השלכות, עלויות ואפקטיביות של מספר חלופות נבחרות וכן מיפוי החסמים ליישום החלופות



גיבוש חלופות תמריצים

גיבוש חלופות עבור מבנה התמריצים העתידי, ניתוח היתרונות והחסרונות של כל חלופה ואופן שילובה במכרז החדש

שלבי העבודה בפרויקט



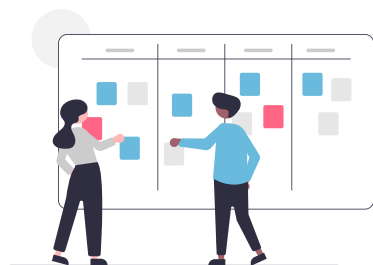
מיפוי מצב קיים וסקירה משווה

ניתוח מבנה התמריצים הקיים כיום וסקירת מבני תמריצים מובילים בתחום מישראל והעולם

תוצרי השלב:

- מיפוי מצב התמריצים הקיים
- סקירה בינלאומית ובישראל
- סקירת ספרות רלוונטית
- סיכום תובנות עיקריות שעלו בתהליך

שיטת העבודה



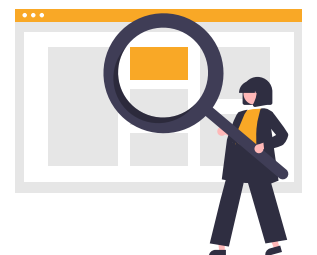
ריכזנו וניתחנו

ריכזנו את כל החומרים שעלו מתוך המחקר, הישיבות, והספרות המחקרית, גיבשנו תובנות מרכזיות אשר נכחו באופן מובהק, חידדנו את הכשלים, התמריצים והאתגרים הקיימים והפקנו תובנות לגבי השלבים הבאים.



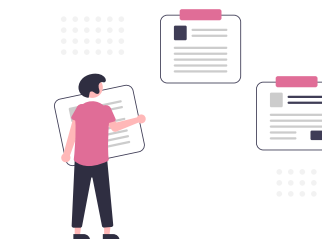
נפגשנו

נפגשנו עם מגוון בעלי תפקידים וגופים אשר מעורבים בשוק הסיעוד וזאת על מנת לקבל נקודות מבט שונות על מבנה השירות כיום והתמריצים הפועלים בתוכו על בעלי העניין



חיפשנו וחקרנו

הכרנו לעומק את עולם הסיעוד בקהילה, את תהליך קבלת הגמלה ואופן מימושה. בחנו מודלים נוספים מהארץ לתמרוץ שיפור השירות.



קראנו

ביצענו סקירה של החומרים שנשלחו אלינו תוך בחינת התוכן בהיבט תיאור המצב הקיים ובחינת מערך התריצים הקיים כיום

פעולות שבוצעו במסגרת השלב הראשון

ישיבות מיפוי

בוצעו ישיבות עם בעלי העניין הרלוונטיים שהוגדרו לטובת חילוץ תובנות מרכזיות על ענף הסיעוד ומערך התמריצים

משרד הבריאות (אגף רכש, אגף גריאטריה)

משרד הרווחה (אגף רכש)

הביטוח הלאומי

ג'וינט אשל

אגף תקציבים

חברות סיעוד

מטפלות

סקירת חומרים

בוצעה סקירת החומרים שנשלחו יחד עם חומר שנאסף במהלך ישיבות האפיון ובמחקר עצמי:

◁ מסמכי הוועדה הבינ-משרדית

◁ דו"ח מסכם

◁ שיתוף ציבור

◁ סקירה בינלאומית

◁ מחקר של מכון ברוקדייל על מקבלי הקצבה

◁ דו"ח הביטוח הלאומי על הרפורמה בסיעוד

◁ הסקר החברתי 2019 – הלמ"ס

◁ המכרז לבריאות התלמיד (משרד הבריאות)

◁ מכרז הקודים הגריאטריים – מוסדות סיעודיים (משרד

הבריאות)

◁ מכרזים של משרד הרווחה

◁ מחקרים אקדמיים מהעולם (7 מחקרים מ-3 מדינות שונות)

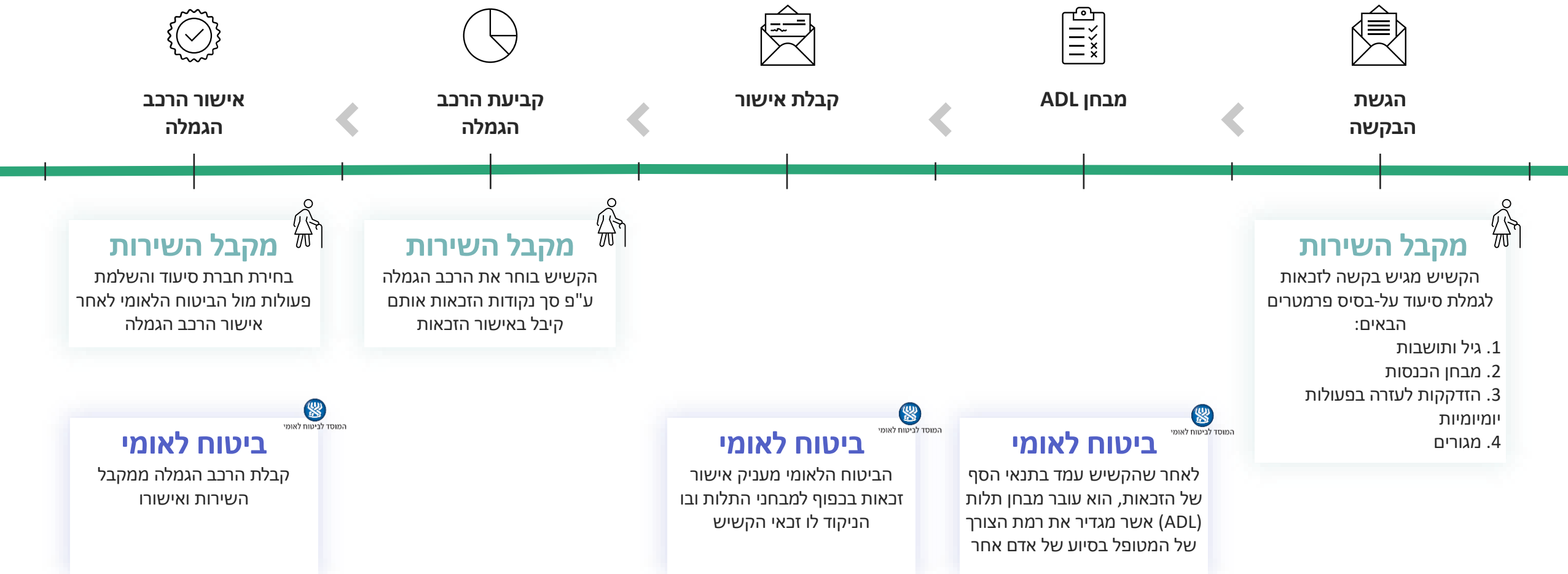
* במסגרת שלב זה לא התקבל ולכן לא נסקר מכרז הסיעוד החדש הצפוי להתפרסם בקרוב.

מיפוי מצב קיים

1. תהליך הזכאות ומבנה הגמלה
2. ניתוח בעלי עניין
3. ניתוח תמריצים לפי בעלי העניין

מבנה גמלת הסיעוד

תהליך הגשת בקשה לגמלת סיעוד



מבנה גמלת הסיעוד

רמות הזכאות של גמלת הסיעוד

רמה 6	רמה 5	רמה 4	רמה 3	רמה 2	רמה 1	
בין 9.5-10.5 נקודות תלות	בין 8-9 נקודות תלות	בין 6.5-7.5 נקודות תלות	בין 5-6 נקודות תלות	בין 3.5-4.5 נקודות תלות	בין 2.5-3 נקודות תלות	נקודות תלות 
30 שעות	26 שעות	21 שעות	17 שעות	10 שעות	5.5 שעות	שעות טיפול שבועיות 
עד 4 שעות שבועיות לקצבה בבספ ללא אישור. בין 4-10 שעות דורש אישור מיוחד	עד 4 שעות שבועיות לקצבה בבספ ללא אישור. בין 4-9 שעות דורש אישור מיוחד	עד 4 שעות שבועיות לקצבה בבספ ללא אישור. בין 4-7 שעות דורש אישור מיוחד	עד 4 שעות שבועיות לקצבה בבספ ללא אישור. בין 4-6 שעות דורש אישור מיוחד	עד 4 שעות טיפול לקצבה בבספ. כל שעת טיפול שווה ל-204.7	1,408 ₪ לחודש	קצבה בבספ 
2,049 ₪ לחודש	1,844 ₪ לחודש	1,434 ₪ לחודש	1,229 ₪ לחודש	819 ₪ לחודש	1,408 ₪ לחודש	סכום מקסימלי 



מבנה גמלת הסיעוד

השירותים הניתנים במסגרת שעות הטיפול



עזרה בנטילת תרופות

- סיוע לקשיש בעת נטילת התרופות
- להזכיר לקשיש לקחת תרופות ו/או להגיש לו את התרופות.
- להגיש לקשיש כוס מים לנטילת התרופה.
- סיוע טכני בנטילת התרופות



עזרה בניהול משק הבית

- סידור וניקוי הבית
- טאטוא
- ניגוב אבק
- שטיפת רצפות בחדר הקשיש אחזקה
- בסיסית של ניקיון המטבח
- ניקיון היגייני של האמבטיה והשירותים
- בישול אוכל, תוך התאמה למצב התזונתי של הקשיש
- כביסה קלה ביד או כביסה במכונת כביסה
- גיהוץ
- קניות וסידורים מחוץ לבית



טיפול סיעודי אישי

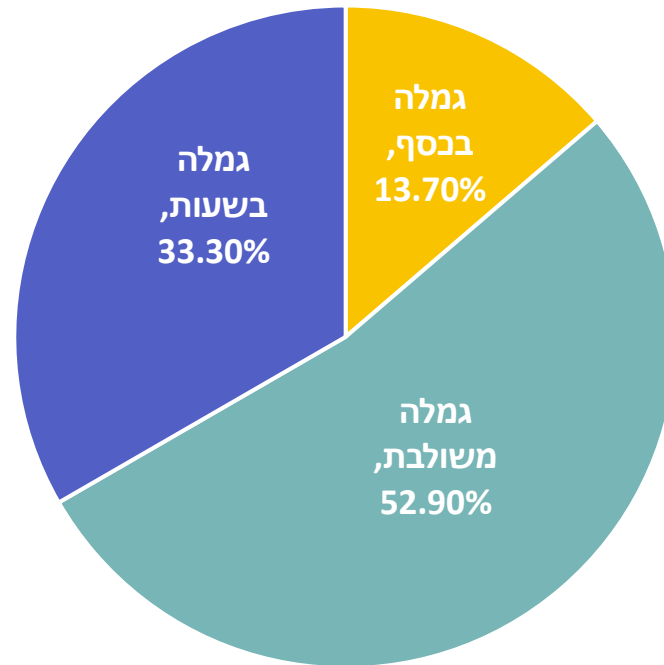
- הלבשה
- אכילה
- רחצה
- טיפול בהיגיינה אישית
- החלפת מוצרי ספיגה ומצעים
- נידודות בבית ומחוץ לבית
- השגחה

מבנה גמלת הסיעוד

נתונים על מקבלי הגמלה

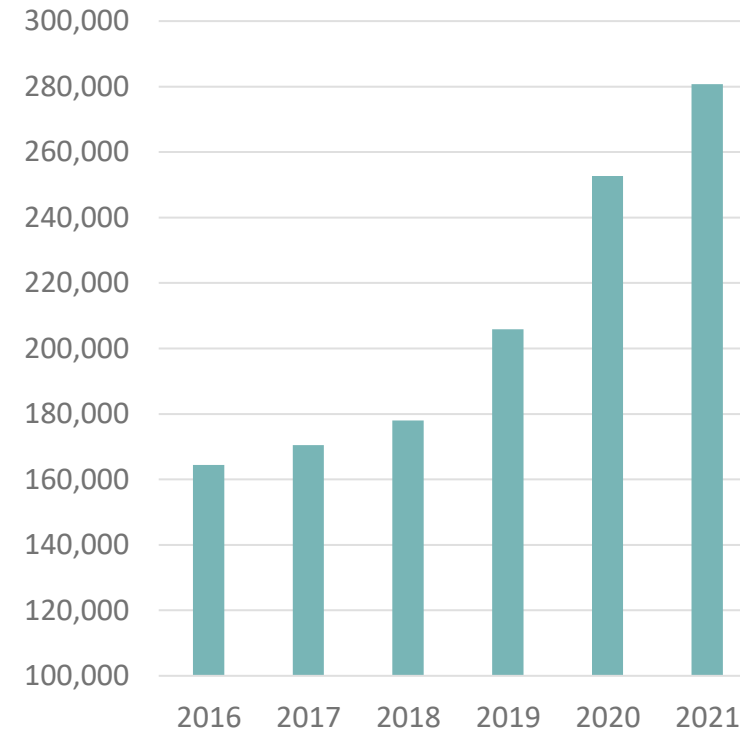
מתוך: דוח לכנסת על הרפורמה בסיעוד (נובמבר 2018) ינואר 2022, הביטוח הלאומי

התפלגות הזכאים לפי סוג הגמלה הנבחר (אוק' 2021)



ניתן לראות כי שני שליש ממוקבלי השירות בחרים בשילוב כלשהו של גמלה כספית בחלק מזכאותם. חשוב לציין כי הנתון של הגמלה המשולבת מוטה היות ובמרבית רמות הגמלה לא ניתן לקבל את כל הגמלה בכסף

גידול במספר הזכאים הכולל



החל משנת 2018 חלה עלייה בקצב הגידול של מספר הזכאים.

בעלי העניין שנותחו במסגרת הפרויקט



חברות סיעוד פועלות כיום ברחבי הארץ



- חברות הסיעוד מעסיקות מטפלות. ים בשכר מינימום שעותי
- החברות אחראיות על מתן שירותי הסיעוד בקהילה לזכאי הגמלה ע"פ כמות השעות שאושרה להם ע"י בטל"א
- החברות מדווחות על קושי רב בגיוס מטפלות. ים לצורך מענה לביקוש ההולך וגדל
- בני משפחה מטפלים מועסקים גם הם ע"י חברות הסיעוד

82.4%

מהזכאים שבחרו בקבלת הגמלה
בשעות טיפול מרוצים מהשירות אותו
הם מקבלים מחברות הסיעוד

4%

שולי הרווח הרשמיים
בתחומי הרווחה

ציטוטים מראיונות שבוצעו עם בעלי עניין



"אין מנוס ממעבר להכשרה
יותר איכותית ומערכתית"

"יש חשש כי תמריצים טובים
אשר ידירו את האוכלוסיות
הקשות יוכלו להוביל את אט את
החברות לעבר טיפול פחות
בחולים קשים"

"חברות הסיעוד הינן שותפות
למדינה בטיפול ולא ספקיות
בלבד"

"יש לקבוע סטנדרטים גבוהים
של הכשרה אך לא להפריט את
השירות כליל. ההכשרה מגדירה
באופן בסיסי את השירות שאנו
נותנים למטופל"

חברות הסיעוד

כ-173 אלף < שהינם 3.2%~ מכלל השכירים במשק (מתוכם כ-40,000 עובדים זרים) מטפלות.ים



- רק 30% מכלל המטפלות עוברות הכשרה כלשהי לתפקיד הטיפולי
- רבות מהמטפלות הינן ממעמד סוציו אקונומי נמוך
- המטפלות מועסקות בשכר שעתי ללא התחשבות בותק או הכשרה
- אין תגמולים על עבודה עם מקרים מורכבים
- כיום אין ציר התקדמות/פיתוח אישי בענף הסיעוד

38%

מסך המטפלות.ים הינן
עולות

50%

שכר המטפלות.ים ביחס
לשכר הממוצע במשק

30%

מהמטפלות.ים נושרות
מהענף במהלך השנה
הראשונה (הערכה)

88%

שיעור הנשים בענף
הסיעוד

המטפלות.ים

ציטוטים מראיונות שבוצעו עם בעלי עניין



"מטפלת יכולה למצוא מטופל
שנפטר בביתו, ועוד באותו היום
ישלחו אותה למטופל אחר. אין
שום ליווי פסיכולוגי ונפשי"

"לנו יש התחייבות כלפי החברה
והמטופל, ולחברה אין
התחייבות לא כלפינו ולא כלפי
המטופל"

"הקורס היום לא נותן כלום,
שום ידע"

"חברות הסיעוד רוצות להתעשר
על חשבוננו"

נותנים עזרה ללא תמורה כספית לבן משפחה

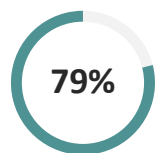
כ-1.2 מיליון
21% מהאוכלוסייה



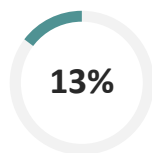
- העסקת בני משפחה בתור מטפלים בשכר הינה פרקטיקה שהולכת וצוברת תאוצה בישראל לאור העלייה הגדולה בביקוש למטפלים עם הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים
- בני המשפחה המטפלים אינם עוברים כל הכשרה ואינם מלווים ע"י גורמי מקצוע
- העסקת בני משפחה מתבצעת בתיווך של חברות הסיעוד



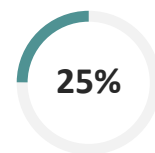
מנותני העזרה עושים זאת יותר מ7 שעות בשבוע



מנותני העזרה אינם גרים עם קרוב המשפחה שלו הם עוזרים.



מהעובדים במשק הנותנים עזרה לבן משפחה מדווחים על פגיעה בעבודה



מסך המטפלים בשכר הינם בני משפחה של מקבלי השירות (הערכה)

בני המשפחה

זכאים לגמלת סיעוד נכון ל-2022



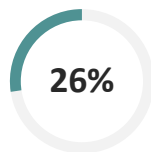
כ- 290,000



- רבים מהזקנים וממקבלי השירות הסיעודיים מסתמכים על בני משפחתם בסיוע יומיומי
- מרבית הזקנים בישראל מזדקנים בביתם, אך רבים מהם נצרכים לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות
- הפעולות בהם נדרשים מקבלי השירות לסיוע משתנות מאדם לאדם ומעת לעת.



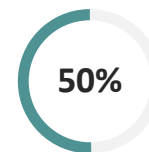
מכלל הזקנים בישראל
חיים בקהילה ולא
במוסדות



מכלל הזקנים בארץ
זכאים לגמלת סיעוד



עלייה בכמות הזכאים
מתחילת הרפורמה



מדרדרים מרמה 1 לרמה
2 בתוך כשנה

מקבלי השירות

גורמים משמעותיים בבחירת הגמלה:



מערכת תמיכה משפחתית וחברתית

כאשר יש מערכת תמיכה זכאים רבים יותר נוטים לעבר גמלה בכסף



ניסיון עבר עם מטפלות

ניסיון חיובי/שלילי יכול להשפיע על ההחלטה הנוכחית האם לעבור לגמלה בכסף או להישאר עם גמלה בעין



מצב כלכלי

מחסור כלכלי ומעמד סוציאקונומי נמוך מעודד בחירה בגמלה בכסף



מקבלי השירות

מחקר אודות אפיון מקבלי גמלת סיעוד 1 ו-2

מכון ברוקדייל בהזמנת הביטוח הלאומי*

המחקר בדק את המאפיינים הייחודיים של בעלי זכאות סיעודית 1 ו-2 במטרה להתחקות אחר פרופילים ספציפיים וזאת על מנת לאפשר התאמה טובה יותר של הטיפול והשירות לכל מקבל שירות.

המחקר בוצע בעקבות שינויים ניכרים שהתרחשו במבנה הגמלה בעקבות הרפורמה של שנת 2018:

- גידול של יותר מ-100,000 זכאים מאז הרפורמה
- עלייה של 6 מיליארד ₪ בהוצאה הציבורית על סיעוד
- מעבר מגמלה בעין לגמלה משולבת וגמלה בכסף

*ד"ר יפית כהן, ד"ר איילת ברג-ורמן, ערית אייזיק, ד"ר שירלי רזניצקי. "אפיון מקבלי גמלת סיעוד 1 ו-2", מרץ 2022

מקבלי השירות

מחקר אודות אפיון מקבלי גמלת סיעוד 1 ו-2 – ממצאים מרכזיים: פרופילים מרכזיים לזכאי הגמלה



מצבי בריאות מורכבים

מצב בריאותי

בעיות בריאות

- מספר מחלות יחד

רמת תפקוד

- מוגבלות קלה-בינונית
- יש פוטנציאל לחזרה לתפקוד קודם

דפוס שימוש בגמלה

- גמלה משולבת

צורך בעזרה

- IADL
- ADL
- ניידות



צורך בשימור תפקוד

מצב בריאותי

בעיות בריאות

- בעיה כרונית מרכזית אחת קבועה

רמת תפקוד

- מוגבלות בינונית
- אין צפי לחזרה לתפקוד קודם

דפוס שימוש בגמלה

- גמלה משולבת

צורך בעזרה

- IADL
- ניידות



צורך בשיקום - בדרך חזרה לתפקוד

מצב בריאותי

בעיות בריאות

- בעיות אורתופדיות כגון שבר (כתף/ מפרק ירך) או ניתוח בעקבות שחיקת סחוס או נפילה

רמת תפקוד

- מוגבלות קלה-בינונית
- יש פוטנציאל לחזרה לתפקוד קודם

דפוס שימוש בגמלה

- גמלה בכסף

צורך בעזרה

- IADL
- ADL – ליווי בעיקר סמוך לאירוע
- ליווי

מקבלי השירות

מחקר אודות אפיון מקבלי גמלת סיעוד 1 ו-2 - מסקנות והמלצות המחקר

מסקנות



- האפשרות לבחור בין צורות גמלה שונות מגביר את תחושת האוטונומיות של מקבל השירות
- ישנם 3 גורמים משמעותיים בבחירת תמהיל הגמלה: מערכת התמיכה המשפחתית, ניסיון עבר עם מטפלות, מצב כלכלי
- כיום המטפלת כמעט ואינה עוסקת בפעולות לשימור תפקוד מקבל השירות
- התאמה והכשרה לפי פרופיל עשויים לשפר משמעותית את איכות הטיפול ואת מצב מקבל השירות

המלצות



- בניית תכנית טיפול על פי הפרופיל של הזכאי
- תכנון והפעלת תוכניות הכשרה ייעודיות למטפלות לפי סוג מקבל השירות (שיקום, שיפור, מורכב)
- הרחבת תכולת התפקיד ותפקוד המטפלות לנושא שימור תפקוד ודחיקת תלות
- הוספת טכנולוגיות להשגחה ולצורך חברתי
- בשיקול לשינוי במערך התמריצים יש לבחון מה היתרון והחסרון לכל פרופיל בפני עצמו

ניתוח התמריצים במצב הקיים

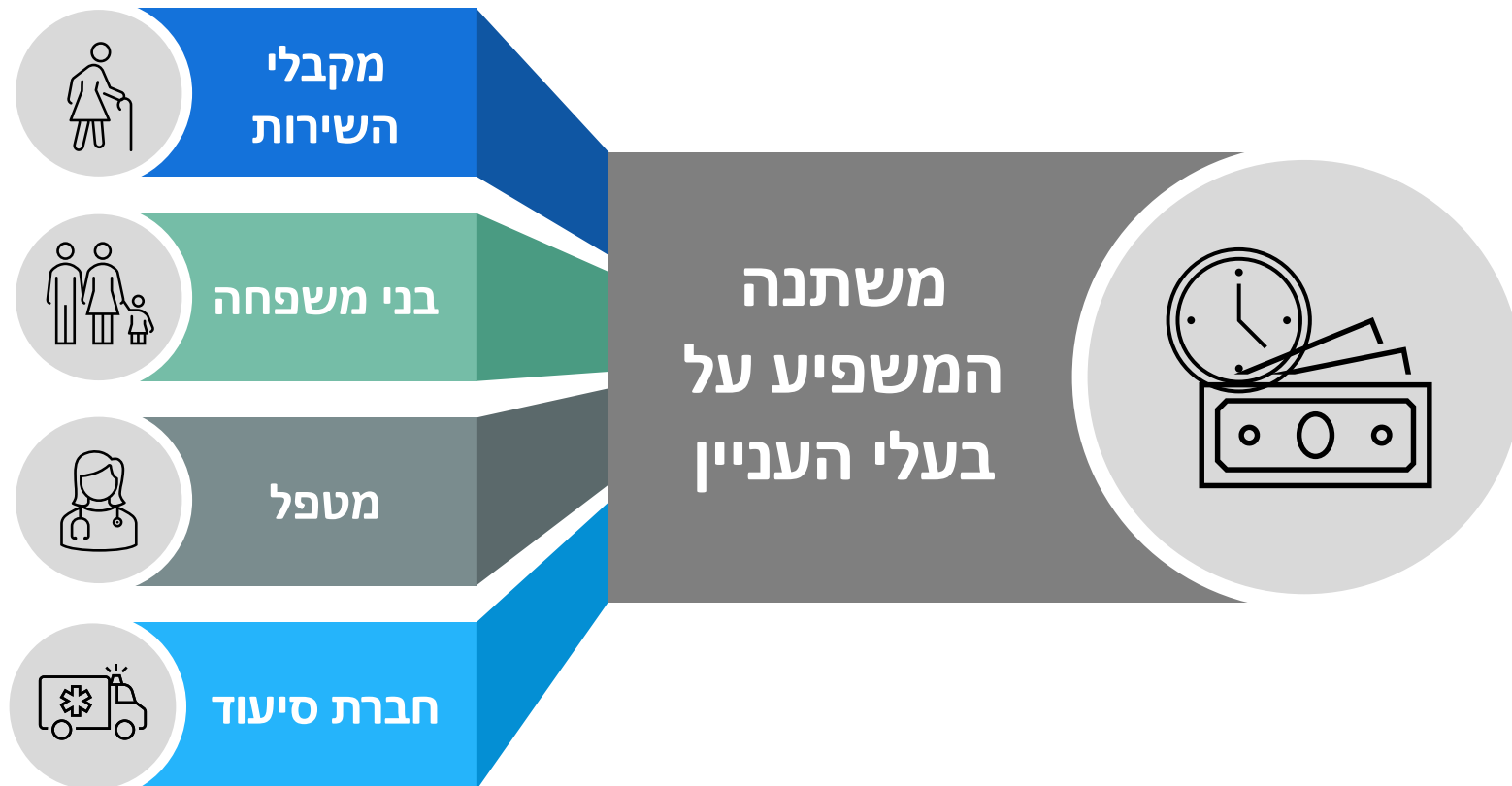
תוצאה והשפעה



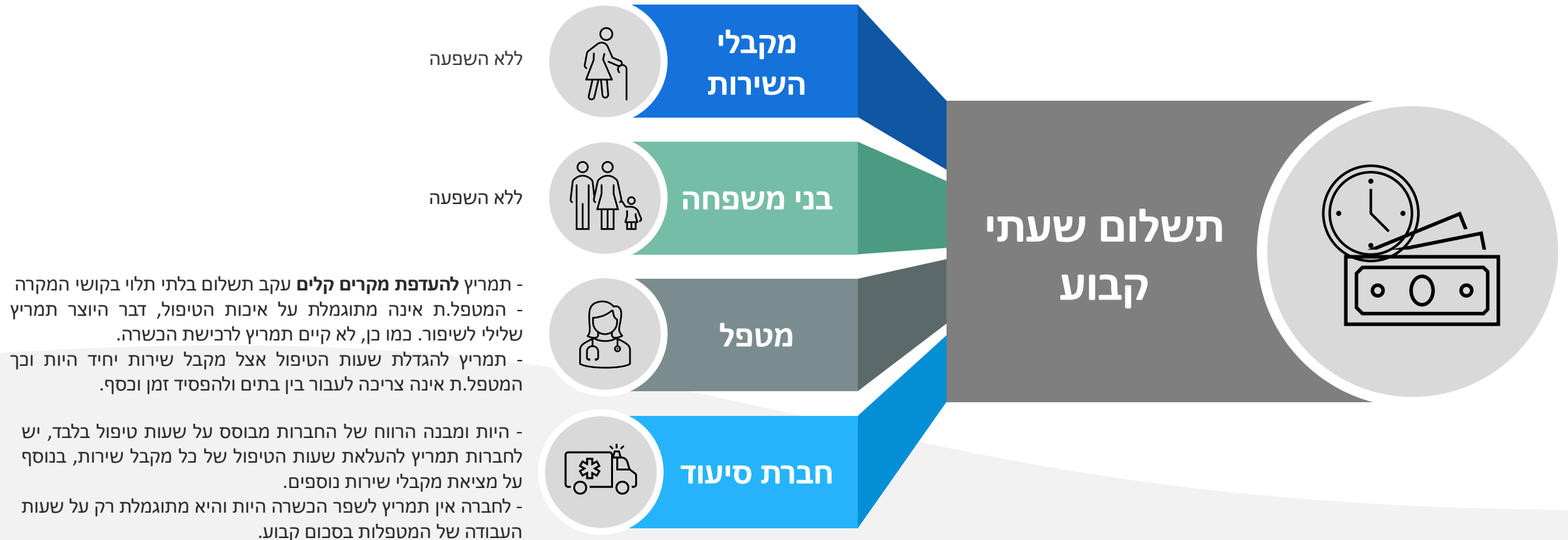
בעלי עניין



משתנה משפיע



ניתוח תמריצים לפי מאפייני המודל הקיים



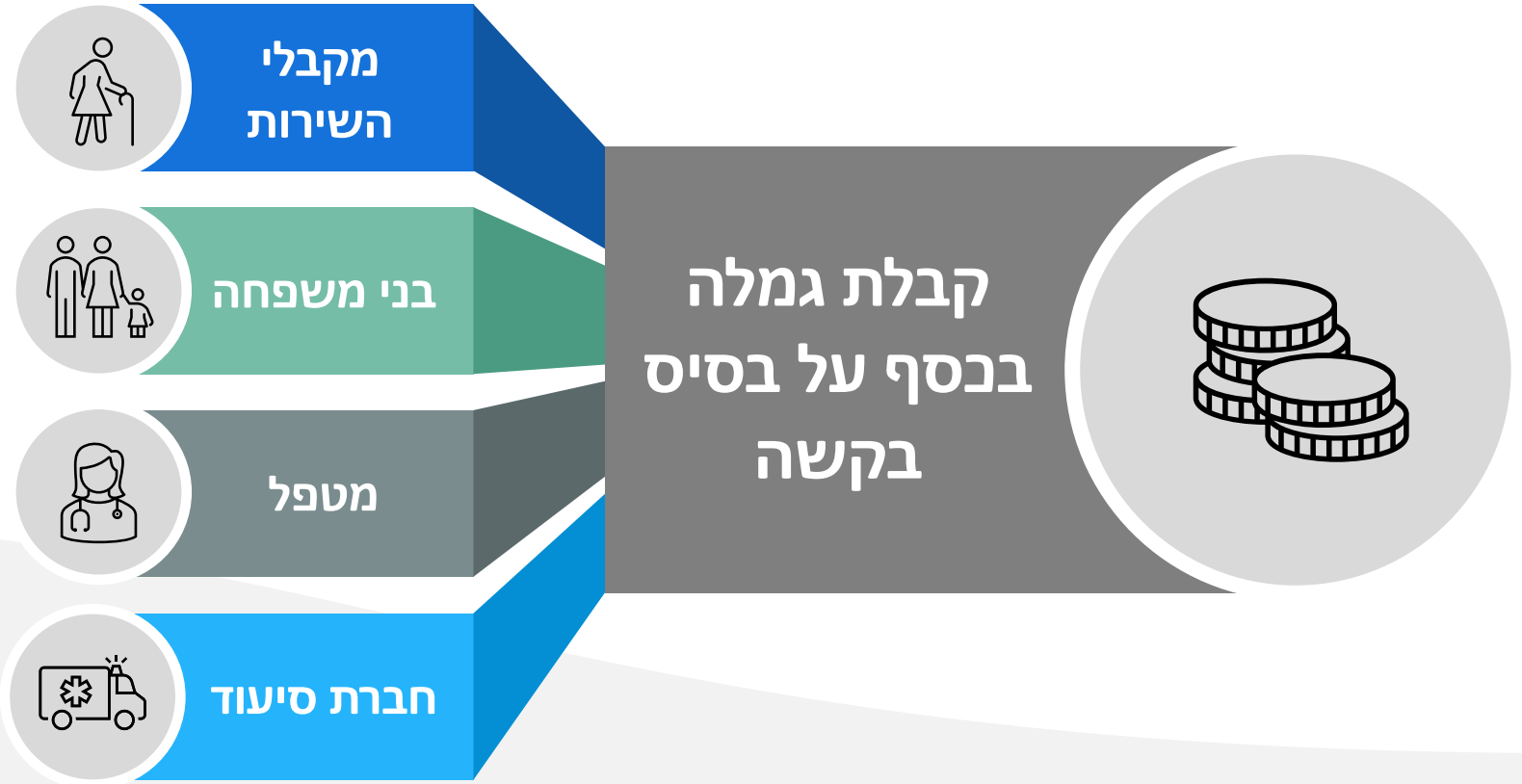
ניתוח תמריצים לפי מאפייני המודל הקיים

- האפשרות לקבלת הגמלה בכסף מתמרצת הפחתה בשעות הטיפול.
 - כניסה של כסף ישירות לחשבון עשויה לעודד שימוש לצרכים שאינם טיפוליים בהכרח.
 - האפשרות לקבלת הגמלה בכסף (בעיקר ברמות הנמוכות) מתמרצת הגשת בקשה לגמלה עבור כלל אוכלוסיית הזכאים.

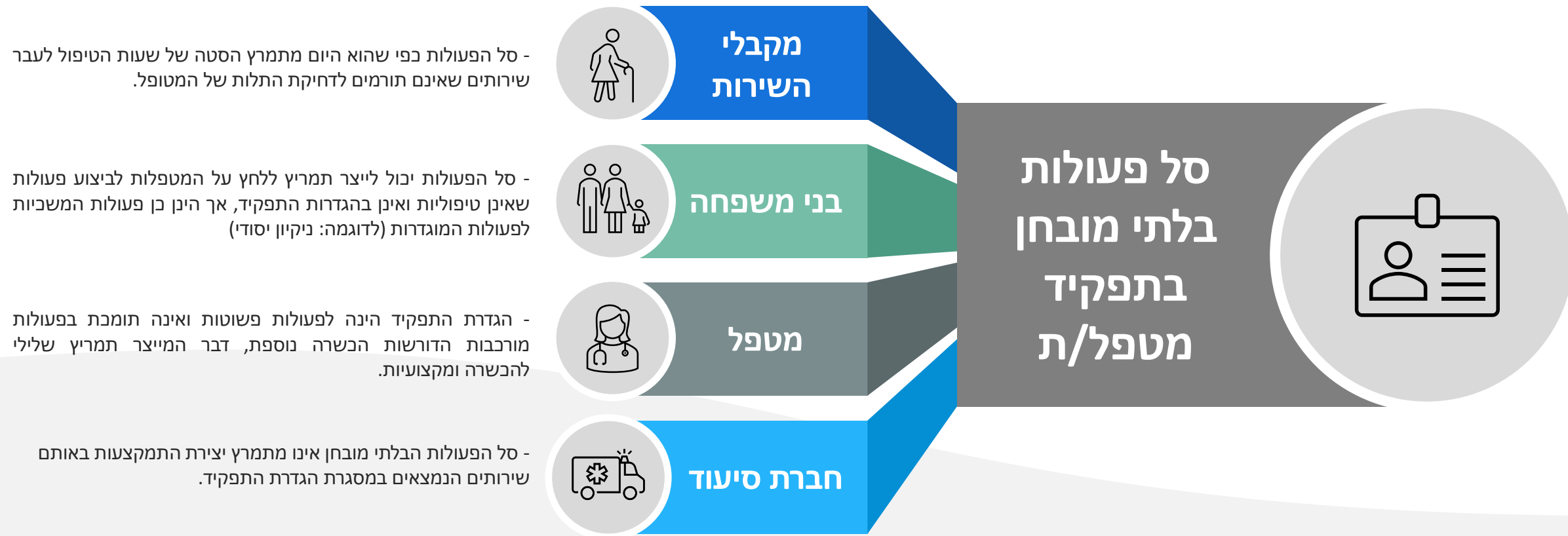
- כניסת הכסף לחשבון מקבל השירות יכולה לייצר תמריץ לשימוש בכסף שלא לצורך הטיפול.

- היכולת של מקבל השירות לבחור בין קבלת שעות לבין גמלה כספית יכולה לייצר תמריץ אצל המטפל. לשיפור הטיפול היות וכך יגדל הערך של שעות הטיפול בעיני מקבל השירות והוא יוכל לבחור פחות גמלה כספית ויותר שעות טיפול.

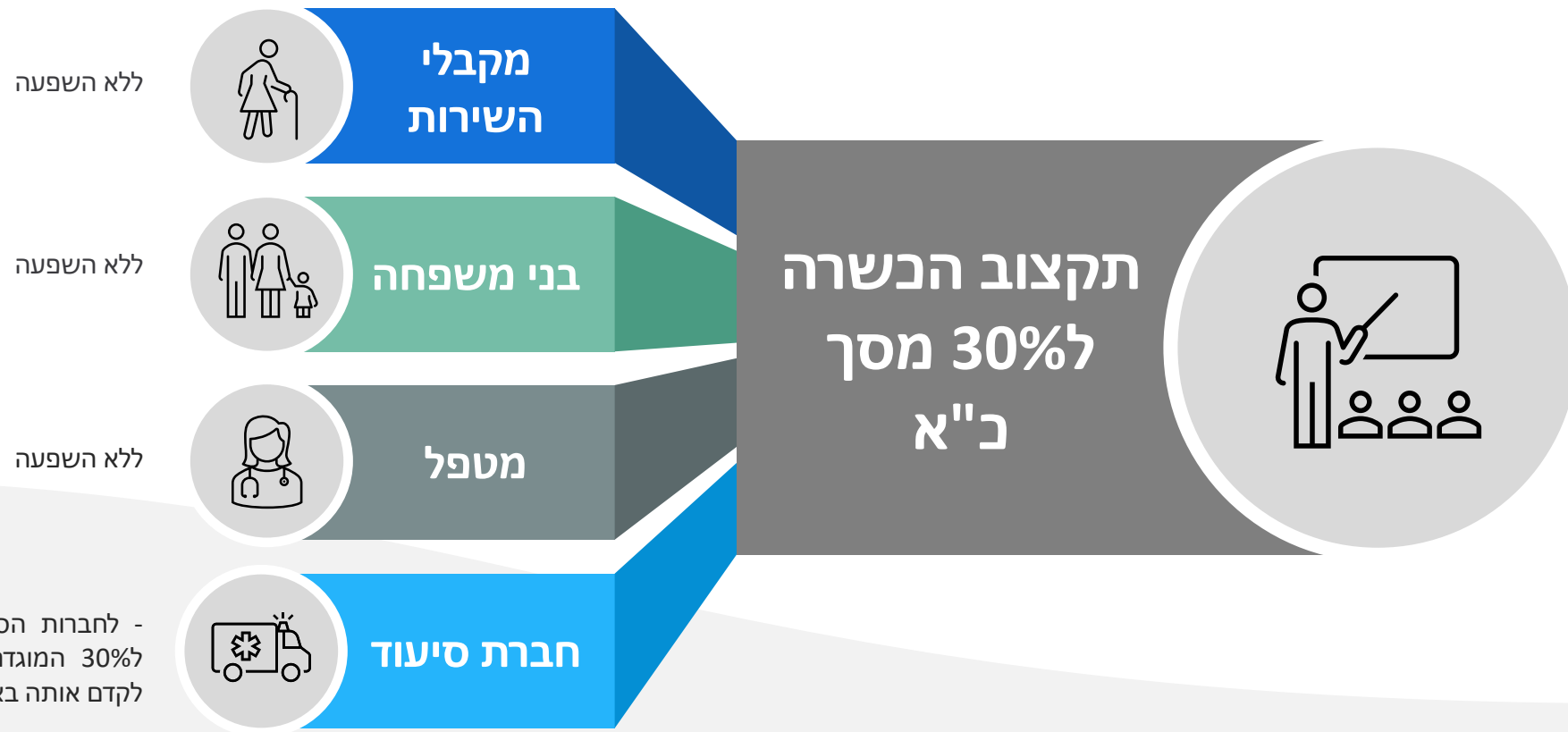
- אפשרות הבחירה יכולה לייצר תמריץ לשיפור השירות בכדי להגדיל את השעות בהן יבחר מקבל השירות וכך תגדל הכנסת החברה.



ניתוח תמריצים לפי מאפייני המודל הקיים



ניתוח תמריצים לפי מאפייני המודל הקיים



- לחברות הסיעוד תמריץ שלילי להשקעה בהכשרה מעבר ל-30% המוגדרים היות והם אינם מתוגמלים או מתומריצים לקדם אותה באופן אחר.

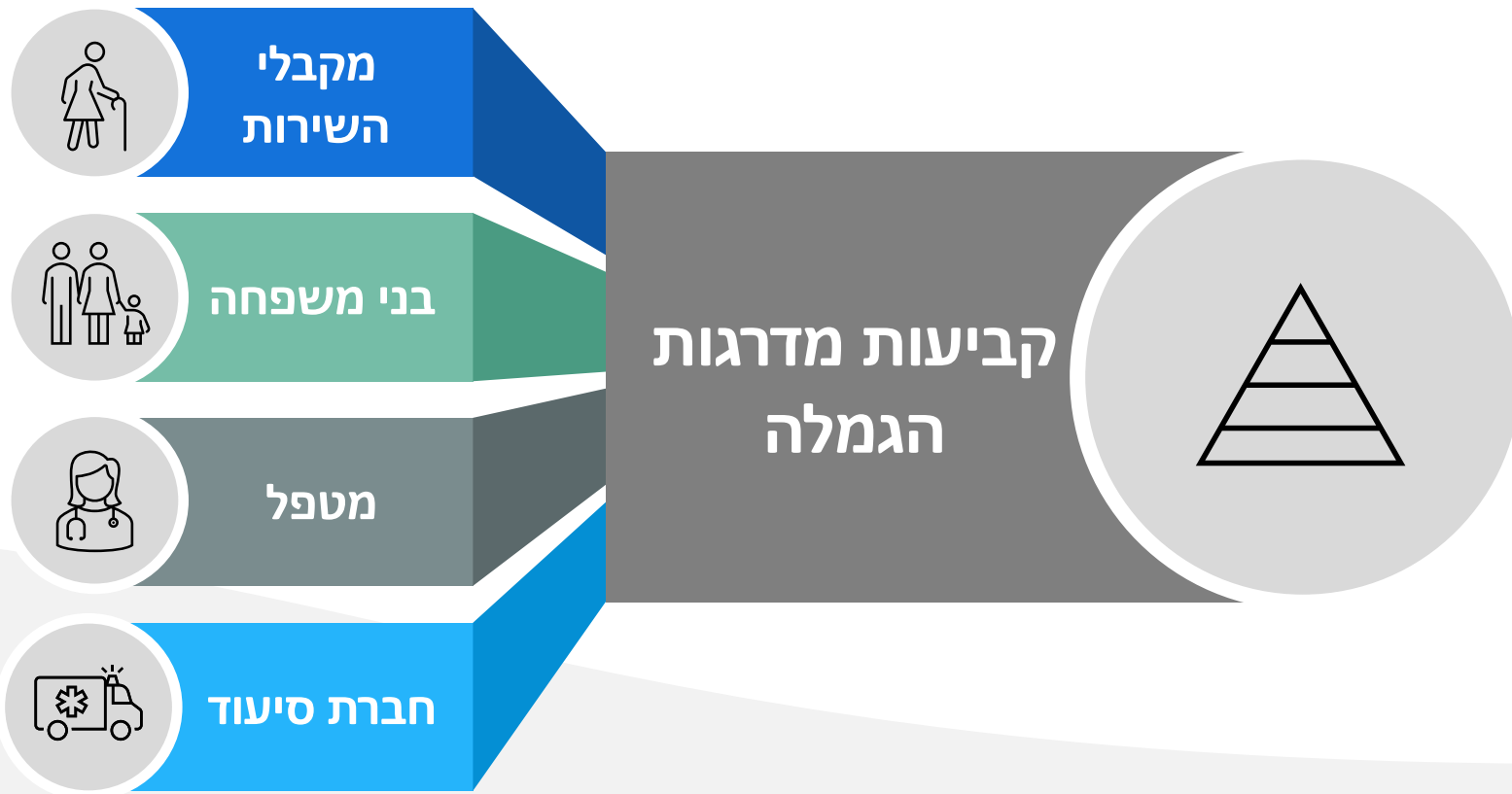
ניתוח תמריצים לפי מאפייני המודל הקיים

- להגשת בקשה להחמרה לא יכולה להיות השפעה שלילית על מקבל השירות, דבר אשר יכול לייצר תמריץ להגשת בקשות להחמרה בתכיפות יתרה.

- כמו מקבלי השירות, גם למשפחה אין מניעה מלהגיש בקשה להחמרה במצב, דבר היוצר תמריץ לדחיפת מקבל השירות להגשת עליה בגמלה

ללא השפעה

לא השפעה



מקרי בוחן בישראל

1. משרד הבריאות
2. משרד הרווחה

מודל ה"קודים הגריאטריים" עליו מתבסס המכרז:



בחירת המוסדות

המוסדות נבחרים במכרז ע"ב קריטריונים, ורק מתוך מוסדות אלו ניתן לבחור מקום אשפוז לחולה גריאטרי



בקרה שותפת

מוסדות אלו עוברים בקרה שוטפת ע"י המשרד



תמרוץ טיפול במחלות זיהומיות

מבחן תמיכה לתמרוץ כלכלי אשר נועד למנוע אשפוזים של חולים בבתי חולים ציבוריים



משרד הבריאות

מודל לשיפור איכות האבחון והטיפול במחלות

זיהומיות חריפות

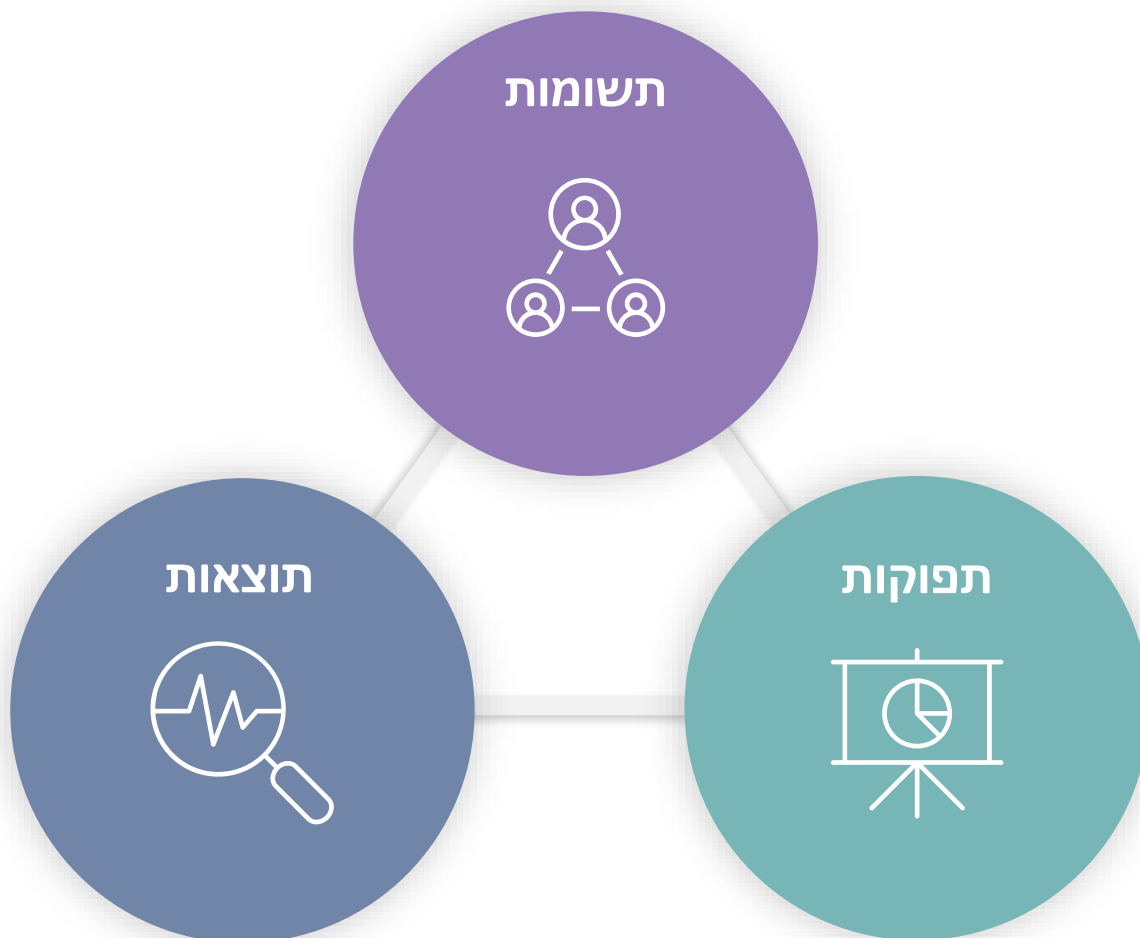
נספח ב'6 למכרז פומבי כלל-ארצי מס' 102-2018 לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים - 2018

כחלק מהמכרז לאספקת שירותי אשפוז גריאטריים, ביצע משרד הבריאות מהלך אשר נועד לצמצם את כמות הפעמים בהם מאושפזים חולים גריאטריים בבתי חולים ציבוריים בתקופת שהותם במוסד גריאטרי. אשפוזים בבתי חולים ציבוריים מעלים את ההוצאה הציבורית וחלק נכבד מהם ניתן למניעה וטיפול במוסד עצמו.

לצורך כך ביצע משרד הבריאות מספר מהלכים אשר נועדו לתמרץ את המוסדות הגריאטריים לשיפור הטיפול והצוות הרפואי בכלל והטיפול במחלות זיהומיות חריפות בפרט.

משרד הבריאות

מבנה התמריץ



התמריץ ניתן למוסדות אשר הגישו בקשה וניתנה להם הרשאה לטיפול במחלות חריפות. מוסדות אלו עמדו בקריטריונים אשר מעידים כי ביכולתם לטפל במחלות חריפות במוסד עצמו.

התמריץ מורכב ממספר מדדים אשר נבדקים במהלך שנת תמריץ, ולאחר שאלו שוקללו בסוף השנה, הבנוס מחולק בין כלל המוסדות הזכאים ע"פ הניקוד הנקבע. המוסד עצמו הינו הגורם היחיד המתומרץ במודל זה.

תשומות

המוסדות הנמדדים נדרשים להציג נוכחות של אנשי צוות בעלי הכשרה מסוימת בשעות פעילות מוגדרות ומקבלים ניקוד על כמות בעלי התפקידים ושעות הפעילות המדווחות

תפוקות

חלק ממודל התמרוץ הינו מאפייני טיפול ומניעה אשר המוסד נדרש לספק לדייריו. בין אלו ניתן למצוא בדיקות רנטגן, חיסונים, היגיינה ועוד

תוצאות

המוסדות נדרשים להגיש דוחות חודשיים בהם דיווח על טיפולים שניתנו, אשפוזים של מטופלים בבתי חולים ציבוריים ועוד

תובנות עיקריות ממודל משרד הבריאות

מערך מדידה

התמריץ מבוסס על היכולת של המשרד למדוד ולערוך ביקורות ובקורות למוסדות השונים.

מבוסס בונוס

התמריץ הכלכלי במודל מבוסס על בונוס למוסדות הנבחרים

המודל אינו מתיימר להשפיע על כלל המוסדות דרך המכרז המרכזי ומאפשר גם מענה בסיסי על המרכז. לעומת זאת, הוא מעודד עשייה נוספת ועליית מדרגה של המוסדות לעבר טיפול מיטבי יותר של החולים

תמריץ משולב

מודל התמריץ מבוסס על מדידת תשומות, תפוקות ותוצאות כאחד

המודל מכיל בתוכו הן מדדי תשומה, הן מדדי תפוקה והן מדדי תוצאה ועל כן יכול להיות אפקטיבי יותר

שירותים הניתנים במסגרת המכרז:



שירותי הדרכה וליווי בבית הלקוח

מספקים מגוון שירותי סיוע ללקוחות בתוך הבית, בקהילה ובמסגרות בקהילה, שמטרתם לשפר את מצבם של לקוחות בהתמודדות היומיומית הנגזרת מצרכים שונים. שירותים אלו מיועדים לארבע אוכלוסיות: **ילדים, בעלי מוגבלויות, אזרחים ותיקים ומשפחות.**



שירותי הדרכה וליווי לפעוטות במסגרת יומית

מטרת השירות הינו לשלב את הפעוט בעל הצרכים המיוחדים כמיטב יכולתו במעון/משפחתון רגיל, וזאת ע"י סייעת שילוב אשר מגיעה למסגרת בה שוהה הפעוט.



משרד הרווחה

אספקת שירותי הדרכה וליווי עבור אנשים עם מוגבלות, משפחות, אזרחים ותיקים וילדים,

בפריסה ארצית

מכרז פומבי דו-שלבי מספר 2020/12

בשנת 2020 פרסם משרד הרווחה את המכרז הראשון מבין 2 מכרזים אשר נועדו לשפר את תחום הסמך המקצועי ברווחה. את שירותי הסמך חילק משרד הרווחה לשתי קטגוריות מרכזיות, הראשונה היא מכרז לשירותים **לשיפור** תפקוד המטופלים ואילו המכרז השני נועד להעניק שירותים **לשימור** תפקוד וסיוע במצבים בהם אין צפי לשיפור מצב המטופל.

המכרז ל"אספקת שירותי הדרכה וליווי עבור אנשים עם מוגבלות, משפחות, אזרחים ותיקים וילדים, בפריסה ארצית" מתמקד באוכלוסייה במצבים בהם מוערך כי ניתן לשפר את מצב המטופלים בתחומים המדוברים. המכרז המשלים טרם פורסם.

משרד הרווחה

מאפייני המכרז

הכשרות

המכרז מגדיר אילו הכשרות מחויב כל עובד מלווה לעבור עם כניסתו לעבודה ולאורך תקופת עבודתו העובד מקבל תשלום הקבוע מראש במכרז על שעות ההכשרה אותן הוא עובר, כאשר התשלום מתבצע ע"י המשרד ועובר לעובד back to back דרך חברת הספק.

מדידה ובקרה

המכרז מגדיר שורה של מדידות אותן צריך הספק לבצע ובהן בדיקת שביעות רצון לקוחות, שביעות רצון של העובדים, מעקב אחר שעות הדרכה ועוד. כמו כן, המשרד מבצע מדידות בעצמו הכוללות תדירות החלפת מלווים, וותק המלווים אצל הספק, הדרכה וליווי מעבר לדרוש ועוד.

תשלום

על מנת לאפשר לספק חופש פעולה וגמישות בתשלום לעובדים, המכרז מגדיר מנגנון תשלום המבוסס על תשלום שעתי משתנה. הספק מחויב להגיש כחלק מהמכרז הצעה לשכר שעתי **ממוצע** אותו ישלם לכלל עובדים. כלומר, יכול לשלם שכר שונה לכל עובד כל עוד בסוף השנה ממוצע השכר עומד על הסכום שהוצע במכרז (בכפוף לסכום מינימום שנקבע)

תהליך קבלת השירות

עו"ס משפחה בונה תוכנית אישית למטופל ומגדיר בה כמות שעות טיפול ויעדים

המטופל בוחר ספק מבין האפשריים באזורו, הספק מחויב להציע מטפל המתאים לתוכנית וליעדים אותם קבע העו"ס

המטפל מגיע לבית המטופל ועובד איתו בהתאם לתוכנית וליעדים האישיים של המטופל, ומדווח שעות בהתאם

העו"ס משפחה עושה בקרה על התוכנית האישית, התקדמות המטופל ועדכון התוכנית במקרה הצורך

תובנות עיקריות ממודל משרד הרווחה

גמישות לספק

מבנה השכר לעובדים אליו מתחייב הספק מאפשר גמישות ותמרוץ עובדים

המכרז מגדיר טווח בו יכול הספק לנהל את השכר לעובדיו, כך שתהיה לו היכולת להעלות ולהוריד שכר בהתאם לצורך וכך ניתן יהיה לתמרץ ולשמר עובדים ולאפשר גמישות מרבית לספק.

חשוב לציין כי המכרז מגדיר שכר מינימום ממנו הספק לא יכול לרדת, וכן שכר מקסימום אותו לא ניתן לעבור.

שימוש בנתונים

שימוש בנתונים ליצירת מגוון תמריצים

המכרז מגדיר מראש כי המדידות והנתונים שיאספו יוכלו לשמש את המשרד כבסיס לתמריץ. בין הפעולות המוגדרות ניתן למצוא: פרסום של התוצאות לציבור, שימוש להחלטת הארכת/הפסקת התקשרות, שימוש כבסיס להחלטה להתקשרות לשירותים אחרים.

מכרז גמיש

המכרז בנוי כך שיאפשר גמישות למשרד בנושא המדידה והתמרוץ

המכרז מכיל מספר סעיפים אשר מאפשרים חופש פעולה לשינויים עתידיים, מתוך הבנה כי יתכנו בקרות, טכנולוגיות ומדדים שהמשרד ירצה להכיל על הספק לאחר תחילת עבודתו בהתאם לאופי ואיכות השירות והתפתחויות טכנולוגיות.

בנוסף, המכרז אינו מגדיר בונוסים ותמריצים לתפקוד מיטבי, אך מגדיר כי למשרד רשות להוסיף בונוסים ותמריצים כאלו בעתיד כפי ראות עיניו.

סקירה בינלאומית

1. מערך הסיעוד בהולנד
2. מערך הסיעוד באוסטרליה
3. מערך הסיעוד באנגליה



מערך הסיעוד בהולנד

סקירת תוכניות עיקריות

ב-2015 בוצעה רפורמה בהולנד, ושירותי סיעוד חולקו בין 3 תוכניות עיקריות: WMO (שירותים סוציאליים), ZVW (שירותי בריאות) ו-WLZ (טיפול חריגים וארוכי טווח).

WLZ #3 - טיפולים חריגים וארוכי טווח

ביסוי לבעלי צורך בטיפול צמוד 24/7, כגון קשישים, בעלי מוגבלויות וחולים במחלות כרוניות. הטיפול ניתן הן במוסדות סיעוד והן בבית המטופל.

לצד מימון מקרנות הביטוח, נדרשת גם [השתתפות עצמית סמלית](#) – תחילה בסכום קבוע, ובמדרגות הבאות בכפוף למבחן הכנסה של מקבל השירות. למקבל השירות ניתנת אפשרות לקבל תקציב אישי ([Personal Budget](#)) ולבצע רכש עצמאי של שירותי הסיעוד.

ZVW #2 - שירותי בריאות

תוכנית ביטוח בריאות חובה לכלל אזרחי הולנד, המכסה שירותי רפואה כללית, תרופות, טיפולי שיניים, בריאות נפש, רופאים מומחים ועוד.

קופות החולים מקבלות מימון מקרנות הביטוח ומתקשרות עם הספקים. הקופות מכוסות באמצעות מנגנון של התאמת סיכונים ([Risk Adjustment](#)) המסדיר מימון ציבורי נוסף בכפוף למצבו של המטופל ומורכבות הטיפול.

WMO #1 - שירותים סוציאליים

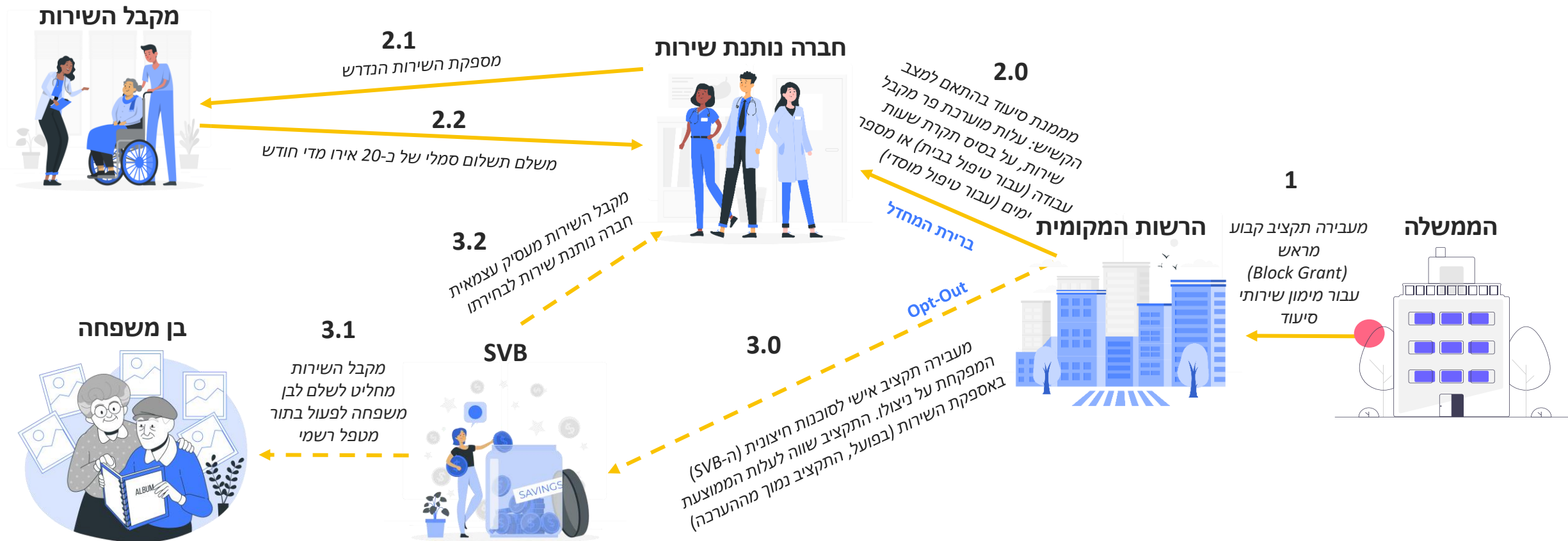
בתוכנית זו שירותים סוציאליים מסופקים ע"י הרשויות המקומיות. הרשויות מקבלות מימון ממשלתי ומתקשרות עם חברות נותנות שירות (private not-for-profit providers).

כל רשות מקבלת מהממשלה תקציב קבוע ([Block Grant](#)) על בסיס נתונים דמוגרפיים וסוציאקונומיים של אוכלוסייתה: הכנסה ממוצעת, כמות הקשישים ועוד. הרשות מתקשרת עם חברות נותנות שירות במודל מכרזי לבחירתה (כמפורט להלן).



מערך הסיעוד בהולנד

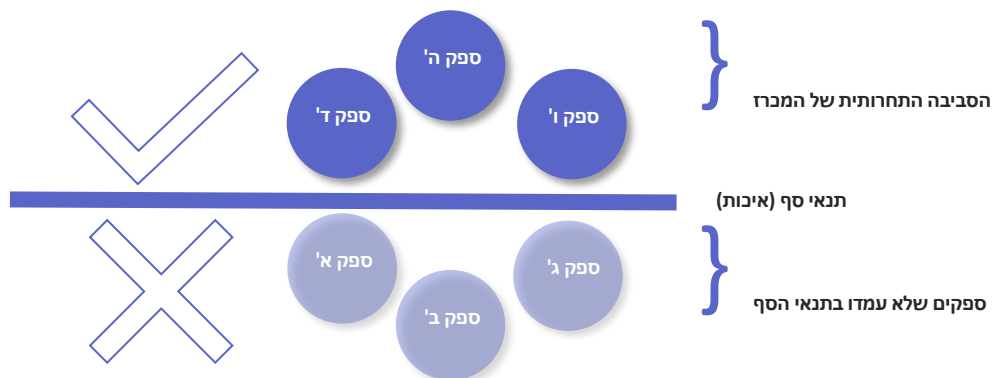
מנגנון המימון של שירותי הסיעוד במודל WMO





מערך הסיעוד בהולנד

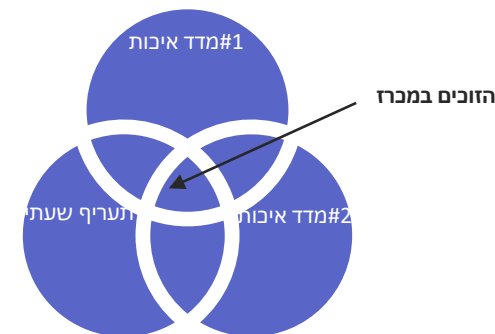
אופני התקשרות עיקריים של רשויות מקומיות עם חברות נותנות השירות במודל WMO



Zeeuws

תעריף וקריטריונים קבועים מראש

הרשות המקומית מציבה מראש תנאי סף לאיכות השירות והביצועים וכן מגדירה את התעריף השעתי. לרוב, נחתם הסכם מסגרת בין הרשות לכלל הספקים העומדים בתנאי הסף – ומקבלי השירות רשאים לבחור ספק מתוך הרשימה



MEAT

שילוב תמחור שעתי לצד מדדי איכות

Most Economically Advantageous Tender - הרשות מקיימת מכרז פומבי לציבור במודל היברידי: תעריף שעתי, לצד תמחור על פי איכות השירות. רוב הרשויות המאמצות מודל זה חותמות על הסכמים נפרדים מול מספר ספקים



ספקים פוטנציאליים



1

פנייה ראשונית לרשות המקומית: תחרות בתהליך מכרזי

הרשות המקומית



2

הזוכים במכרז מקבלים מימון פר מקבל שירות

חברות נותנת שירות



3

הזוכים מתמודדים במכרז נוסף בתום תקופת המכרז הקיים

הרשות המקומית



4

הזוכים במכרז העוקב מקבלים תגמול נוסף בהסתמך על ביצועים במדדי איכות שונים



מערך הסיעוד בהולנד - תובנות קיום מדדי איכות ללא התחשבות בכלל מערך התמריצים לא בהכרח מעלה את איכות השירות

חברות נותנות שירות מתבקשות להציג את איכות שירותן לצורך קבלת תקציב גבוה יותר בתהליכים מכרזיים חוזרים (כמפורט בשלבים 3 ו-4). המטרה היא לעודד שיפור באיכות השירותים הקיימים, אולם, בפועל הועלו דיווחים רבים מהשטח בנוגע לירידת איכות השירות.

עלה, כי ייתכן שחוסר האפקטיביות של מדדי איכות בעידוד שיפור השירות נובע מהתנגשות בין התמריץ לשיפור האיכות לבין תמריצים אחרים. כיום חישוב התקציב למקבל השירות מתבסס על סך שעות העבודה המוערכות, אולם, חברה נותנת שירות מתוגמלת פר מקבל שירות, ללא קשר לשעות העבודה שבוצעו בפועל. כתוצאה מכך, קיים תמריץ חזק בקרב חברות נותנות שירות לספק שירות לכמות גבוהה של קשישים, תוך הקדשת תשומות מינימאליות לכל קשיש בפרט. ייתכן ותמריץ זה גובר על התמריץ לשיפור איכות השירות.



Key Challenges



אמצעי בקרה

דווח על קושי להגדיר מראש תוצאות רצויות שניתן יהיה למדוד באופן סדיר, עקבי ומערכתי ולאכוף את השגתן



הפחתה בשעות הטיפול

ההתייעלות הובילה לפחות שעות סיעוד שסופקו למקבלי שירות, ונדרש לתת מענה נקודתי ונפרד לבעלי צורך בטיפול אינטנסיבי יותר



פגיעה ביחס האישי

המטפל עלול להיות ממוקד בהשגת התוצאות, באופן שמותיר פחות זמן להקדיש לאינטראקציה עם מקבל השירות

Best Practices



חיסכון לרשויות

ה-SDD דיווחה על חיסכון של 15%-20% בכמות שעות הטיפול שחויבו – באופן שסייע להתמודד עם קיצוץ התקציב הממשלתי



התייעלות של הספקים

המעבר לתגמול לפי תוצאות, ולא לפי שעות, מעודד את המטפל לבצע את אותם המשימות והיעדים בטווח זמן קצר יותר



שביעות רצון של מקבלי השירות

התהליך המשותף של הגדרת התוצאות הרצויות הגביר את תחושת המעורבות של מקבלי השירות, ורובם דיווחו על שביעות רצון גוברת

מערך הסיעוד בהולנד - תובנות מעורבות מקבל השירות בהגדרת המטרה עשויה להוביל לשיפור השירות

בינואר 2013, מספר רשויות באזור Drechtsteden שבהולנד (כ-260 אלף תושבים) [אימצו מודל חדש](#) ברכש של שירותי סיעוד: חתימת הסכמים מול ספקים המבוססים על תוצאות הטיפול, במקום על תעריף שעותי.

השלבים המרכזיים בהטמעת מודל התוצאות:

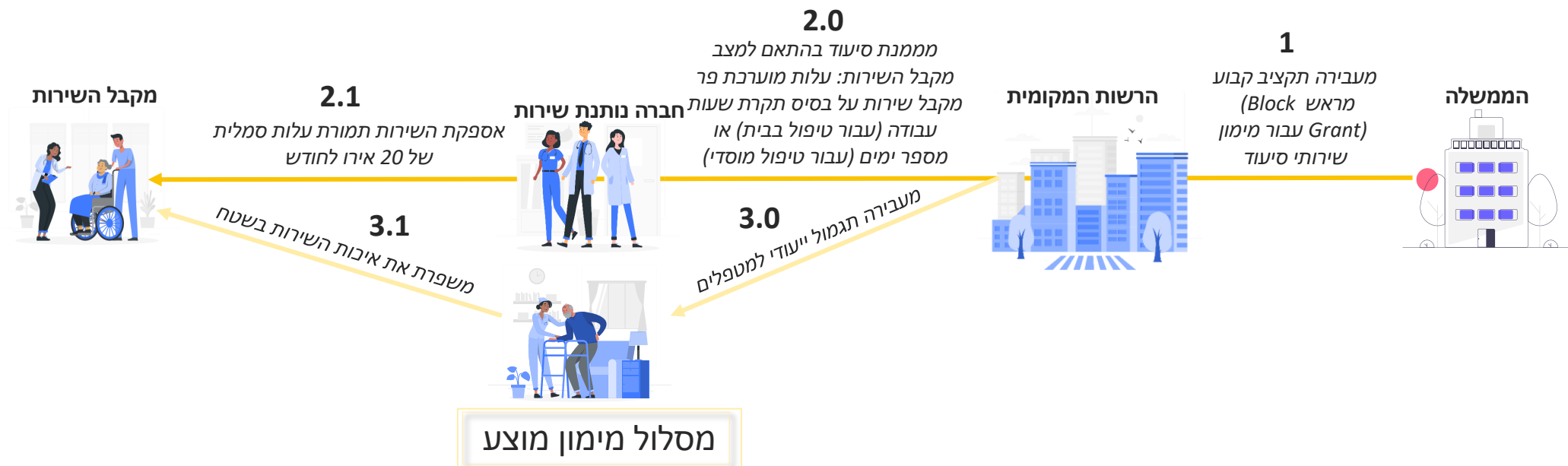
1. הספק ומקבל השירות מגדירים במשותף את תוצאות הטיפול הרצויות. מקבל שירות שאינו שבע רצון רשאי להחליף ספק בכל עת.
2. הן הספק והן מקבל השירות חותמים על תוכנית טיפול (Support Plan), שבה מפורט בהרחבה מהן התוצאות הרצויות.
3. תוכנית הטיפול מועברת אל יחידת השירותים החברתיים האזורית של the Regional Social Services Unit for The Drechtsteden Area - SDD.
4. ה-SDD והספקים מגדירים מראש אמצעים לבקרה על התוצאות – חלק ממקבלי השירות מקבלים שיחות טלפון, ומבקרים מטעמה של חברה חיצונית מקיימים ביקורים תקופתיים בבתייהם של מקבלי שירות.

תהליך ניהול השינוי היה מאתגר במיוחד ביישום המודל החדש, וסיפק לקחים רלוונטיים – Best Practices מחד, ואתגרים שצצו בדרך מאידך



מערך הסיעוד בהולנד- תובנות

היעדר תגמול ייעודי למטפלים והשפעתו על עומסים בשטח



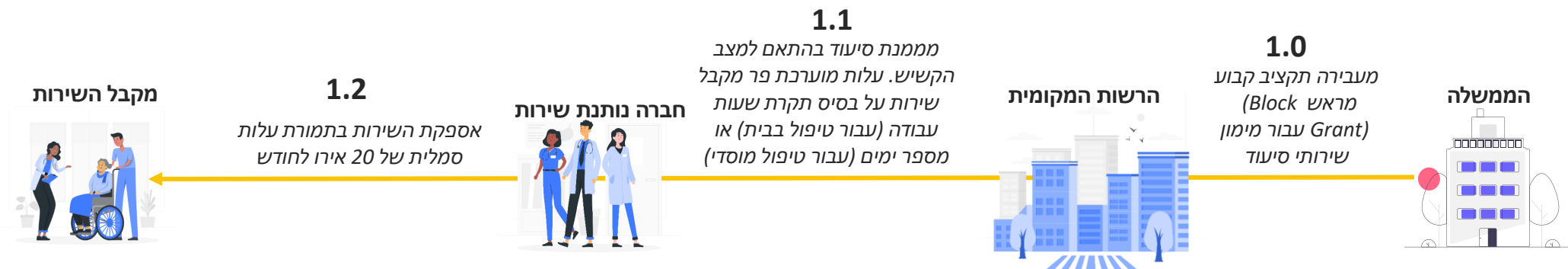
בעוד שמודל התמריצים הקיים במערך הסיעוד בהולנד מעודד התייעלות כלכלית של חברות נותנות שירות, קיים לחץ על המטפלים בשטח לעבוד במקביל על משימות רבות ככל שניתן, עובדה המטילה על המטפלים עומס כבד וגוררת פגיעה ברמת השירות.

בשנים האחרונות בוחנים אפשרות לייצר תמריץ כלכלי ייחודי למטפלים, וזאת על מנת לאזן בין התייעלות כלכלית לבין איכות השירות.



מערך הסיעוד בהולנד- תובנות

היעדר מבחן הכנסה מגדיל באופן משמעותי את הביקוש לשירות



כתוצאה מהרפורמה ב-2015 לא קיים מבחן הכנסה ומקבלי הסיוע במסגרת התוכנית נדרשים אך ורק לתשלום סמלי של כ-20 אירו בחודש, ללא כל תלות בהכנסתם. מהלך זה הוביל להגברת צריכת השירות והעלאת עומסים על מערך הסיעוד.

ללא מבחן הכנסה ההשפעה המיידית היא העלאת הכוללת בתחום הסיעוד. בטווח הרחוק, השילוב של העלייה בביקוש עם הזדקנות האוכלוסייה עלול להקשות על מטפלים בשטח ולהוביל לירידה הדרגתית באיכות השירות.



מערך הסיעוד בהולנד- תובנות

מתן שירותי סיעוד על ידי בני משפחה עשוי להוציא כח אדם בעל הכשרה ממעגל העבודה



במידה ומקבל השירות מחליט לקבל תקציב אישי, עליו לבחור ספק שירות באופן עצמאי. משום שקשישים רבים כבר מקבלים שירותי סיעוד מבני המשפחה, לעתים מקבל השירות מעדיף לשלם את תקציבו האישי לבן משפחה ולמעשה להעסיקו בתור ספק שירות.

תמיכה בבני משפחה באספקת שירות לקשישים מעודדת את השארתו של הקשיש בקהילה, אולם, התגמול מתמרץ בני משפחה לצאת משוק העבודה. קיימות משפחות רבות אשר לא מצליחות להתפרנס עם משכורות גבוהות יותר מהתגמול המוצע, וכתוצאה מהמצב הקיים מפחית אחוזי השתתפות בשוק העבודה.

מציאת איזון בין תמיכה בבני משפחה לבין שיקולים מקרו-כלכליים יכולה לבוא לידי ביטוי בקביעת תגמול דינמי פר משפחה אשר תואם למצבם הכלכלי ולצרכי הקשיש.



מערך הסיעוד באוסטרליה

סקירת תוכניות עיקריות

Homecare Packages #3

התוכנית כוללת שירותי סיעוד בבית, כמו רחיצה וגיהוץ, ניקיון וגינון.

מאז 2017, הממשלה מספקת **תקציב אישי ישירות למקבל השירות**, ולא לספקים עצמם. מקבל השירות בוחר מתוך רשימת ספקים מאושרים המתפרסמת באתר אינטרנט "עודי" ("My Aged Care").

מקבלי השירות מסווגים ל-4 רמות:

בעלי צרכים בסיסיים, בעלי צרכים מעטים, בעלי צרכים בינוניים ובעלי צרכים גבוהים.

Residential Aged Care #2

מיועדת לקשישים הזקוקים לטיפול צמוד במוסד. **רשימת הספקים נבחרת בהליך מרכזי תחרותי - [Aged Care Approvals Round](#)**, ואלה מתוקצבים ישירות ע"י הממשלה.

מקבלי השירות משלמים "עלויות מחיה קבועות", ונדרשים גם לשלם על המגורים במוסד (**Accommodation Payment**) בהתאם לרמת ההכנסה והנכסים של כל קשיש (Means Tested Fee).

התשלום מתבצע בשני אופנים: פיקדון (Refundable Accommodation Deposit - RADs); תשלום יומי מסובסד (Daily Accommodation Payment - DAPs); או שילוב של שניהם.

Commonwealth Home Support #1 Programme (CHSP)

מרבית הקשישים באוסטרליה המקבלים שירותי סיעוד מכוסים ע"י תוכנית זו. המטרה: לספק **שירותים בסיסיים** להגברת עצמאותו של הקשיש. התוכנית כוללת סיוע בתחזוקת בית, ציוד וטכנולוגיה מסייעת, ארוחות ושירותי מזון, שירותי אחיות, תחבורה ועוד.

אין שום מתכונת מובנית של השתתפות עצמית של מקבל השירות, והספקים רשאים לגבות כזו עפ"י שיקול דעתם – בכפוף למסגרת ה-"**Client Contribution Framework**" הממשלתית שמכתיבה תקרה לסכום הנגבה.



מערך הסיעוד באוסטרליה

מנגנוני המימון של שירותי הסיעוד

מענק ישיר לספקים





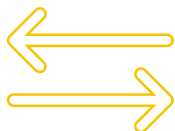
סל שירותים בשליטת מקבל השירות

הסל בשליטת מקבל השירות, אבל ממוקד בשירותים הספציפיים שלהם הוא זכאי



חופש בחירה

מקבל השירות רשאי לבחור בעצמו את הספק שיעניק לו את השירותים שלהם הוא זכאי



אפשרות לשנות

בכל שלב של הטיפול, מקבל השירות רשאי לעזוב את הספק הקיים ולהחליפו באחר

מערך הסיעוד באוסטרליה

הרפורמה במערך הסיעוד

מערך הסיעוד האוסטרלי עובר בימים אלה רפורמה מקיפה, שבמרכזה מעבר של כל 3 תוכניות הסיעוד למודל חדש. במסגרתו, מוקצה למקבל השירות תקציב אישי ע"י הממשלה, המיועד לממן את סל השירותים שלהם נמצא זכאי. התשלום מתבצע במתכונת של תשלום עבור שירות ("Fee For Service").



הקשיש בעצמו הוא שבוחר את החברה נותנת השירות מתוך רשימת הספקים המאושרים. בתורה, החברה נותנת השירות [מסדירה את התשלום](#) עבור השירות מול הסוכנות הממשלתית "Services Australia", המעבירה את התשלום מתוך אותו תקציב אישי של מקבל השירות.

הרפורמה מציבה את מקבל השירות במרכז על בסיס כמה עקרונות מרכזיים: יצירת סל שירותים בשליטתו, חופש בחירה ואפשרות לשנות



מערך הסיעוד באוסטרליה - תובנות

כשלי שוק מובנים בתחום הסיעוד עשויים להשפיע על המנגנון ומערך התמריצים





מערך הסיעוד באוסטרליה- תובנות

הגדרת רגולציה מסוימת בתחום הסיעוד דורשת מערך בקרה או תמריצים על מנת לוודא את יישומה

הגבלת חופש הבחירה בפועל

לספקים רבים ישנו תמריץ מובהק לקבל דיירים במודל ה-RADs – פיקדון המופקד מראש עבור השהות המוסד – שכן, כספי ה-RADs מהווים "הלוואה ללא ריבית", כסף נזיל ומיידי. לכן, במיוחד בתקופות שבהן הריבית הממוצעת במשק גבוהה יותר, יעדיפו החברות נותנות השירות לקבל פיקדון אישי.

קשישים דיווחו כי במעמד המו"מ מול מוסדות הסיעוד, [הופעל עליהם לחץ לבחור בתשלום באמצעות RADs](#), וקבלתם למוסד אף הותנתה בכך.

עיקרון חופש הבחירה

בעת הכניסה למגורים קבועים במוסד סיעודי, ניתנת לקשיש לבחור אחת מבין שלוש אופציות התשלום הקיימות עבור המגורים. מרבית הקשישים באוסטרליה השוהים במוסדות סיעודיים מעדיפים לממן את דמי המגורים באמצעות מודל ה-DAPs, שבו הם משלמים עבור מגוריהם במוסד במתכונת של "דמי שכירות" יומיים.

עצם קיומן של אופציות שונות למימון דמי המגורים, שנועד להיטיב עם מקבלי השירות, לא בהכרח מיתרגם בפועל לחופש בחירה עבורם.

לאור התמריצים הכלכליים, מוסדות הסיעוד הגבילו את חופש הבחירה של מקבלי השירות.



מערך הסיעוד באוסטרליה - תובנות

נדרשת בחינה הוליסטית של תחום הסיעוד על מנת למנוע הסטה של תקציבים משירות אחד לאחר

בעוד שתוכנית ה-CHSP מסובסדת כמעט במלואה ע"י הממשלה, ב-Homecare Packages נקבעת רמת הסבסוד בהתאם לרמת הצרכים של מקבל השירות וסיווגו באחת מארבע קטגוריות. בפועל יוצא, קשישים הזכאים לרמת סבסוד נמוכה יותר ב-Homecare Packages עלולים להעדיף את ה-CHSP, המצריכה מהם תשלום נמוך יותר, על מנת לחסוך עלויות.

יש להסתכל על כלל מרכיבי מערך הסיעוד והתמריצים השונים ולבצע שינויים בצורה הוליסטית שתביא בחשבון כיצד משפיעים התמריצים על יחסי הגומלין בין תוכניות סיעוד שונות.

CHSP



שירותים בתוכנית ה-CHSP מצריכים לרוב השתתפות עצמית נמוכה יותר של הקשיש

מקבל השירות



הסעת עלויות

Homecare Packages



קשישים הזקוקים לטיפול מקיף ואינטנסיבי יותר לא פונים לתוכניות המקבילות כדי לא לשלם יותר – ועלולים שלא לקבל את הטיפול הנחוץ



מערך הסיעוד באנגליה

סקירת תוכניות עיקריות

שירותי הסיעוד הציבוריים באנגליה ממומנים במרבית המקרים ע"י הרשויות המקומיות, שלרוב מעסיקות חברות פרטיות או ארגונים ללא מטרות רווח עבור אספקת השירותים. תקציב שירותי הסיעוד של כל עירייה משתנה בהתאם לסדרי העדיפויות שלה.

Short Term Care #2

מסלול זה מתמקד בשירותי סיעוד נקודתיים לטווח קצר, המחולקים לשתי קטגוריות מרכזיות:

- Short Term Support to Maximise Independence (ST-Max) - שירותי סיעוד מוגבלים בזמן, שנועדו להגביר ככל הניתן את עצמאותו של הקשיש כדי להפחית – או לייתר לגמרי – את הזדקקותו לשירותי סיעוד קבועים וממושכים.
- Other Short Term Support - שירותי סיעוד נוספים שלא נכללים במסלול הראשון, בעיקר שירותי חירום.

Long term care #1

המסלול מכסה שירותי סיעוד קבועים ומתמשכים, וכולל הן טיפול בתוך הקהילה והן במוסדות סיעוד. מימון הטיפול נקבע בכפוף להערכת המורכבות של הקשיש (Needs Assessment), ולאחר מכן מבחן הכנסה (Financial Assessment). הזכאים לקבל מימון של שירותי סיעוד מהרשות המקומית מקבלים תקציב אישי, שאותו ניתן לנצל עבור שירותי סיעוד בביתו של מקבל השירות, או לחילופין עבור סיעוד מוסדי בבתי אבות, מרכזי יום או מסגרות אחרות.



מערך הסיעוד באנגליה

מבחן הערכת המורכבות לאספקת שירותי סיעוד ציבורי

השלב הראשון בקבלת שירותי סיעוד ציבוריים באנגליה הינו מבחן הערכת מורכבות, שבו קובעת הרשות המקומית האם צרכיו של מבקש השירות מצדיקים סבסוד של השירות, ואם כן – סוג והיקף השירות הנדרש. הערכת המורכבות מתבצעת ב**כמה שלבים**:



עבור מבקשי שירות שנמצאים זכאים, הרשות המקומית **מגבשת תוכנית סיעוד**, המפרטת מהן התשומות שיוקצו עבור השגת היעדים שהוגדרו מראש. רשויות באנגליה נוהגות לסווג את מקבלי השירות **לארבע קטגוריות** של צרכים: מועטים (Low), בינוניים (Moderate), נרחבים (Substantial) וקריטיים. בשלב הבא, מתבצע מבחן ההכנסה.



- בהתאם לממצאים, הרשות מחליטה אם מבקש השירות רשאי לקבל סיעוד מסובסד, **לפי שלוש שאלות מנחות**:
1. האם צרכיו של מבקש השירות קשורים ללקות/מחלה פיזית או מנטלית?
 2. האם מבקש השירות אינו מסוגל לממש בעצמו שניים או יותר מיעדי הסיעוד ללא סיוע חיצוני?
 3. האם לשירות תהיה השפעה משמעותית על רווחתו של מבקש השירות?



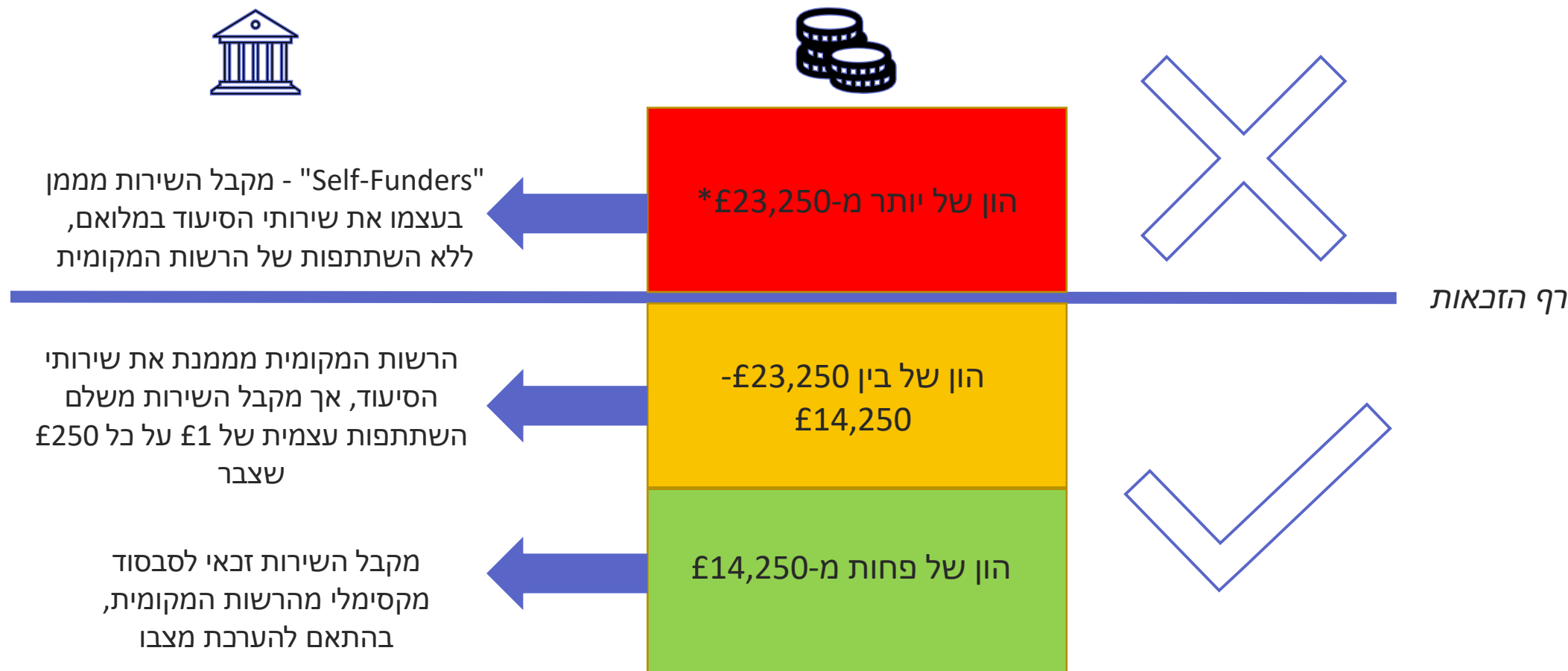
עובד מהרשות המקומית נפגש עם מבקש השירות **ומגדיר עימו את יעדי הסיעוד** הרצויים, מתוך "סל יעדים" מוגדר: הקפדה על תזונה והיגיינה, ביגוד הולם, קיום קשרים משפחתיים, שמירה על סביבה בטיחותית ועוד. נציג הרשות מעריך אם ובאיזו מידה היעדים הללו יכולים לקבל מענה באמצעות שירותי סיעוד.



מערך הסיעוד באנגליה

מבחן הכנסה לאספקת שירותי סיעוד ציבוריים

בתום הערכת המורכבות, רמת המימון של שירותי הסיעוד נקבעת בהתאם [לאמצעים הכלכליים](#) (Financial Means) של מקבל השירות: שווי הכנסותיו השוטפות, כגון פנסיה, לצד ההון שברשותו: נכסים, עסקים, חסכונות והשקעות, על פי סף (Threshold) הקבוע בחוק



*במסגרת [רפורמה שעליה הכריזה ממשלת בריטניה](#), ועל מנת להרחיב את נגישות הסיעוד הציבורי, החל מאוקטובר 2023 רף הזכאות העליון למימון ציבורי יעלה מ-£23,250 ל-£100,000, ואילו התחתון יעלה מ-£14,250 ל-£20,000



מערך הסיעוד באנגליה

מסלולים שונים לניהול תקציב הסיעוד האישי

לאחר ביצוע הערכת מורכבות ומבחן הכנסה, הזכאים למימון שירותי סיעוד מקבלים מהרשות המקומית [תקציב אישי](#). תקציב זה יכול להיות מנוהל ע"י הרשות, אך זו [מחויבת בחוק להציע](#) גם מסלול נוסף, של תשלום ישיר למקבל השירות:



תשלום ישיר למקבל השירות

הרשות המקומית מעבירה לקשיש ישירות את התקציב האישי ומפקידה את הסכום בחשבון הבנק שלו. מקבל השירות מנהל, מארגן ומשלם בעצמו על שירותי הסיעוד. מסלול זה הינו גמיש, ומציע עוד מספר [אפשרויות](#) נוספות, בכפוף לבחירתו של מקבל השירות:

- ❑ ניהול התקציב ע"י הרשות המקומית בחשבון בנק ייעודי, כאשר מקבל השירות הוא שבוחר כיצד להשתמש בכסף.
- ❑ הרשות תשלם ישירות לחברה נותנת השירות, שאותה בוחר מקבל השירות (בניגוד למסלול הראשון, שבו הבחירה נתונה בידי הרשות).
- ❑ הפקדת הכסף בחשבון נאמנות (Independent Living Trust) המנוהל ע"י בן משפחה או קרוב אחר של מקבל השירות, אם הוא אינו כשיר לנהל את התקציב בעצמו.



ניהול ומימון של הרשות

לאחר קביעת זכאותו של מקבל השירות בהתאם להערכת המורכבות ולמבחן ההכנסה, הרשות המקומית היא [שמגבשת תוכנית סיעוד](#) עבור הקשיש, מממנת ישירות ומנהלת אותה.

במסלול זה, הרשות בוחרת ומעסיקה בעצמה חברה נותנת שירות – בעיקר חברות פרטיות וארגונים ללא מטרת רווח – ומשלמת ישירות לספק השירות עפ"י מדדי [תשומות ותפוקות](#) (שעות/ימי טיפול). למקבל השירות במסלול זה אין כלל מעורבות בתהליך הבחירה וההעסקה של החברה נותנת השירות.

בנוסף, ניתנת גם אפשרות לשלב בין שני המסלולים, כך שחלק מהתקציב האישי ינוהל ע"י הרשות, וחלק אחר ישולם ישירות למקבל השירות

מקבל השירות



עשוי לשלם השתתפות עצמית בהתאם להונו האישי



מעסיק עצמאית חברה נותנת
שירות לבחירת מקבל השירות

מנוהל ע"י

מנהלת את התקציב בחשבון בנק "עודי או משלמת
ישירות לחברה נותנת שירות – לבחירת מקבל השירות

חברה נותנת שירות

An illustration showing a female doctor in a white coat and black pants, a male caregiver in a blue uniform, and an elderly female patient in a blue wheelchair. The doctor is on the left, gesturing towards the patient. The caregiver is on the right, holding the wheelchair. The patient is seated in the wheelchair, looking towards the doctor. The background is a simple indoor setting with a window and a potted plant.

מעסיק עצמאית חברה נותנת שירות לבחירתו
מספקת השירות הנדרש

מפקידה תקציב ישירות בחשבון הבנק של מקבל השירות
בהתאם למצבו (Needs Assessment) ולחובו האישי
(Financial Assessment)

הרשות המקומית



ממנת סיעוד בהתאם למצב הקשיש (Needs Assessment) ובהתאם להון האישי (Financial Assessment) לפי מדדי תפוקות

מפקידה תקציב בהתאם למצבו של מקבל השירות (Needs Assessment) ובהתאם להונו האישי (Financial Assessment)

מקרא

ניהול התקציב ע"י
הרשות המקומית

ניהול התקציב ע"י מקבל
השירות



מערך הסיעוד באנגליה - תובנות

השקעה במניעה, שיקום ושימור בקהילה יכולה להפחית את הצורך בסיעוד קבוע בעתיד



חיסכון והתייעלות כלכלית

הטיפול המונעים מפחיתים, ולעתים אף מבטלים לחלוטין, את הצורך בסיעוד מורכב ויקר יותר למקבל השירות בהמשך



הורדת העומס על מערך הסיעוד

בשל היותם ממוקדים וקצרי טווח, שירותי הסיעוד המונעים מפחיתים את התשומות המושקעות בכל מקבל שירות



השאת הקשיש בתוך הקהילה

שירותי סיעוד מונעים עשויים לדחות ולצמצם את הצורך של קשישים לעבור לסיעוד מוסדי קבוע ולהגביר את עצמאותם

במסגרת תוכנית הסיעוד קצר הטווח (Short Term Care), מתמקדות הרשויות באנגליה במתן שירותי סיעוד מונעים (Preventative Services), המוכרים גם כ"סיעוד ביניים" (Intermediate Care). שירותים אלה מוגבלים בהיקף ובזמן, ונועדו למנוע, או להפחית ככל הניתן, הזדקקות של הקשיש לשירותי סיעוד ממושכים ומורכבים יותר.

טיפול הביניים כוללים בעיקר שירותי שיקום והחזרה לכושר (Reablement), הניתנים לרוב עם שחרורו של מקבל השירות מאשפוז בבית חולים כתוצאה מאירוע רפואי כמו שבץ. שירותים אלה אינם כפופים למבחני הערכת מורכבות או מבחני הכנסה, ובששת השבועות הראשונים לאספקתם, הרשות המקומית אינה מורשית לגבות עבורם תשלום.

מצדן של הרשויות, שירותי הסיעוד המונעים מקדמים חיסכון והתייעלות כלכלית: ב-2020/21, דווח כי 32.8% מבין מקבלי השירות בתוכנית ST-Max סיימו את התקופה בתוכנית ללא שום צרכים סיעודיים נוספים.



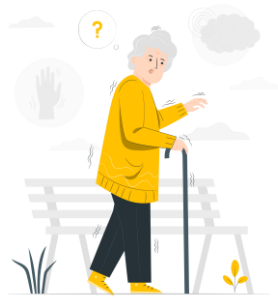
מערך הסיעוד באנגליה - תובנות

מעורבות מקבל השירות בהגדרת המטרה עשויה להוביל לשיפור השירות ומיקודו

"סל היעדים" במבחן הערכת המורכבות לקבל שירותי סיעוד

- ✓ ניהול והקפדה על תזונה
- ✓ שמירה על היגיינה אישית
- ✓ ניהול צרכי הנוחיות (Toilet Needs)
- ✓ הקפדה על לבוש הולם
- ✓ יכולת להתנהל בבית בבטיחות
- ✓ שימור סביבה ביתית ראויה למגורים
- ✓ פיתוח ושימור קשרי משפחה
- ✓ עיסוק בעבודה, הכשרה, חינוך או התנדבות
- ✓ שימוש במתקנים ושירותים בקהילה
- ✓ נטילת אחריות כלפי ילדים (אם יש)

מבחן הערכת המורכבות המונהג באנגליה מציב במרכז את מבקש השירות, תוך מעורבות מרבית של הקשיש בהגדרת הצרכים המותאמים אליו אישית ובבחירת יעדי הסיעוד הרצויים עבורו. הממשלה עיגנה בחוק רשימה קבועה של יעדים מגוונים, מתוכם בוחרים הרשות ומבקש השירות את אלה הרצויים ביותר עבורו (ראו מסגרת). כך, מטרות השירות מוגדרות ומתועדות מראש, תוך השתתפות אקטיבית של מקבל השירות והתאמה מיטבית של השירות להעדפותיו וצרכיו הייחודיים. קשיש שאינו מסוגל לקיים לפחות 2 יעדים בעצמו, זכאי לקבל סיעוד ציבורי (לצד קריטריונים נוספים).



מערך הסיעוד באנגליה- תובנות

מבחן ההכנסה עשוי לייצר חיסכון כספי לצד פגיעה באוכלוסיות מוחלשות

הצבת רף הון אישי למימון הסיעוד עשוי להיות מועיל עבור הממשלה, אך אם אינו בנוי בצורה המיטבית עלול לפגוע במקבלי השירות

פגיעה בנגישות השירות לכלל האוכלוסיות

המודל הקיים מעורר גם ביקורת רבה, ובמרכזה הטענה כי רף של £23,250 בהון אישי לקבלת הסיעוד בעלי הכנסה בינונית הינו נמוך מדי ומדיר רבים ממעגל קבלת השירות. בנוסף, לספקים נוצר תמריץ למקד את השירותים ולתעדף מקבלי שירות שמממנים את שירותי הסיעוד שלהם (Self-Funders), במפורט בשקף הבא:

חיסכון כספי והתייעלות ממשלתית

המודל של שירותי הסיעוד באנגליה, שבו הסבסוד של שירותי סיעוד ממוקד בשכבות מעוטות היכולת באוכלוסייה, מאפשרת לרשויות המקומיות התייעלות לצד חיסכון כספי. חיסכון זה יכול לסייע לרשויות בהגדלת מגוון רכיבי השירות הניתנים למקבל השירות, או, לחלופין, להעניק את השירות לכמה שיותר מקבלי שירות, ובסופו של דבר לתרום לאספקת שירותים איכותיים ועילים יותר עבור אלה הזכאים להם.



מערך הסיעוד באנגליה- תובנות

מבחן ההכנסה עשוי לייצר חיסכון כספי לצד פגיעה באוכלוסיות מוחלשות- המשך

מודל הזכאות למימון שירותי סיעוד כתלות בהון האישי של הקשיש, מתמרצת בפועל את החברות נותנות השירות להתמקד באותה קטגורייה של Self-Funders – מקבלי השירות האמידים ביותר, שמממנים בעצמם את הסיעוד ומסוגלים לשלם יותר עבור השירות.

החברות נותנות השירות גובות סכומים גבוהים יותר מקבוצה זו וכך, ולפי מחקר שנערך באנגליה, מקבלי השירות מקבוצת ה-Self-Funders משלמים בממוצע כ-40% יותר על שירותי סיעוד מוסדיים מאשר מקבלי השירות המסובסדים ע"י הרשויות המקומיות.

כך, החברות נותנות השירות משעינות את המודל העסקי שלהן על Self-Funders, בעוד שהזכאים לשירותי סיעוד ציבוריים אינם נהנים מתחרות על אספקת השירות ומחופש בחירה מלא בין מגוון של ספקים. כפועל יוצא, נפגעת איכות ונגישות השירות עבורם.





תובנות רוחביות: סקירה בינלאומית

#1 הגדרת מדדי תוצאה מאפשרת גמישות וחדשנות בקרב חברות הסיעוד ומייצרת תמריץ לשיפור השירות

מקור התובנה 

מדינות אשר אימצו מודלים המבוססים על מדידת תוצאות הטיפול, מצאו כי המודל מעודד עמידה ביעדים הנמדדים, תוך התייעלות בתשומות המושקעות. בנוסף, חלק מהמדינות סבורות כי מקבל השירות הוא הגורם המסוגל להגדיר בצורה המיטבית מהו השירות הרצוי עבורו ומהן תוצאותיו הרצויות.

בהולנד, חלק מהרשויות יישמו מערך שבו מפעיל השירות והמטופל מגדירים במשותף את תוצאות הטיפול. המיקוד בתוצאות הוביל לירידה בכמות שעות הטיפול שחויבו ותמרץ את החברות להתייעל (כמפורט [להלן](#)).

באנגליה, קיום טיפולים מונעים ומעורבות אקטיבית של המטופל, תרמה אף היא להתייעלות והעלאת איכות השירות (כמפורט [להלן](#)). מענה לסוגיית המדידה ניתן באמצעות "סל יעדים" שמתוכו נבחרים אלה הרצויים ביותר עבור המטופל (כמפורט [להלן](#)).

משמעות התובנה לקובעי מדיניות 

כאשר לוקחים בחשבון מדדי תוצאה, שיתוף של הקשיש בהתאמת הטיפול והגדרת מטרותיו מעצימה את מקבל השירות, עשויה להפוך את הליך הסיעוד לאפקטיבי יותר, וגם להוביל לחיסכון כלכלי עבור הרשויות, באופן שימנע השקעת תשומות עתידיות באותו המטופל.

תובנות רוחביות: סקירה בינלאומית

#2 תמריצים להתייעלות כלכלית, עשויים להשפיע באופן שלילי בכיוון אחר ולכן נדרשת בחינה רב ממדית

מקור התובנה

תמריץ כלכלי שמתמקד בהתייעלות כלכלית בלבד, עלול לעודד את מפעילי השירות לתעדף חיסכון בספי על פני שימור ושיפור של איכות השירות.

בהולנד, הרשויות הפעילו תמריצים שאמנם עודדו חיסכון והתייעלות של חברות הסיעוד (תגמול פר-מטופל ולא פר-שעה) - אך אלה הובילו בשטח ללחץ על המטפלים לטפל בכמה שיותר מקבלי שירות במקביל, באופן שפגע באיכות השירות (כמפורט בשקפים [להלן](#) ו-[להלן](#)).

באוסטרליה, מנגנון הסבסוד בכפוף לרמת המורכבות של מקבל השירות אמנם מעודד התייעלות כלכלית לרשויות, אך גם מוביל ל-Cost-Shifting של מקבלי השירות לתוכנית מקבילה וזולה יותר מבחינתם, על חשבון התאמת הטיפול המיטבי ([להלן](#)).

משמעות התובנה לקובעי מדיניות

לא ניתן להגדיר מודל תמריצים במערך הסיעוד, ללא בחינת השלכות השינוי על כלל השחקנים המעורבים. התייעלות של שירותי הסיעוד מצריכה בנוסף גם הסתכלות הוליסטית ורחבה על כלל בעלי העניין במעגלי השירות המשיקים.



תובנות רוחביות: סקירה בינלאומית

#3 מבחן הכנסה מסייע בניהול ביקושים, אך נדרש לנהל אותו ברזולוציה גבוהה

מקור התובנה 

מבחן ההכנסה מהווה כלי להתייעלות וחסכון בעלויות של שירותים עבור הממשלה. מנגד, מבחן הכנסה כללי יתר על המידה עלול להותיר מחוץ למעגל השירות חלק מהזכאים, שנאלצים לשאת בעלויות הסיעוד בעצמם. כפועל יוצא, עול טיפולי רב יותר עלול ליפול על בני משפחה, ומבקש השירות עלול שלא לזכות לטיפול מיטבי.

בהולנד, אי-קיום מבחן הכנסה היווה תמריץ לצריכה מוגברת של שירותי סיעוד והוצאות הולכות וגוברות מצד הרשויות המקומיות (כמפורט [להלן](#)).
באנגליה, מבחן ההכנסה מסווג את מקבלי השירות הפוטנציאליים לקטגוריות הרמטיות וכלליות אשר משאירות אזרחים הנזקקים לסיוע מחוץ למעגל התמיכה (כמפורט [להלן](#)).

משמעות התובנה לקובעי מדיניות 

תנאי מבחן ההכנסה צריכים להיבנות באופן מודולרי וברזולוציה גבוהה, כך שהנגישות לשירות אינה נפגעת עבור מטופלים שנמצאים על סף המדרגה של מבחן התמיכה, זאת על מנת [לתת מענה לצרכים הכלכליים הייחודיים](#) של מקבלי השירות.



תובנות רוחביות: תמריצים כלכליים במערכי סיעוד

#4 בבחינת התמריצים הכלכליים יש לתת ביטוי לכשלי השוק המובנים בתחום הסיעוד

מקור התובנה 

חוסר האיזון בין השחקנים במערך הסיעוד מגביל את יכולת הממשלה להפעיל תמריצים כלכליים שישפיעו על התנהגותם של מפעילי השירות. חלק ממקבלי השירות אינם כשירים לקבל החלטות כלכליות ולבחור בין מפעילים שמתחרים זה בזה, מה שמקשה להפעיל תמריץ כלכלי על מפעילים לשפר את איכות השירות בכדי להרחיב את מעגל מקבלי השירות.

באוסטרליה, האפשרות למקבלי השירות לבחור בין מגוון מפעילים אינה מתאימה לקשישים הנעדרים את המידע הדרוש, הכשירות או הכלים לבחור בטיפול המיטבי עבורם. אצל מקבלי שירות אלה נוצרת תלות בינם לבין המפעיל, שמגבילה תחרות (כמפורט [בשקף 29](#)). כמו כן, האפשרות לבחור בין מסלולים שונים למימון הסיעוד, מתמרצת את המפעילים לנתב את מקבלי השירות למסלול המשתלם יותר עבורם מבחינה כלכלית (כמפורט [בשקף 30](#)).

משמעות התובנה לקובעי מדיניות 

בעת בניית התמריצים, יש לשקול את כשלי השוק הנובעים מחוסר האיזון בין בעלי העניין השונים במערך הסיעוד, לצורך ניתוח ההשפעות על השחקנים השונים.

סקירת ספרות – פרופ' אייל וינטר

1. רקע לסקירת הספרות
2. סקירת המחקרים
3. סיכום ותובנות

רקע לסקירת הספרות

במסגרת סקירת הספרות נבחרו מאמרים העוסקים בהקשר הסיעודי וזאת בכדי למקד את המחקר ולמקסם את הרלוונטיות שלו לכלל הפרויקט.

נושאי המחקרים

המאמרים שנבחרו עוסקים ישירות בתמריצים, ובהם תובנות חשובות לאופן שבו תמריצים משפיעים על פעולות השחקנים השונים ורמת השירות.

בעלי העניין

המאמרים נוגעים במספר בעלי עניין ובייחוד בחברות הסיעוד (ספקים), במקבלי השירות ובגופים הממשלתיים האחראים על השירות. המחקר העוסק בתמריצים ברמת המטפלים עצמם (כלומר השכירים העובדים אצל הספקים) הינו דל באופן יחסי. ככל הנראה הדבר נובע מהעדר נתונים בנושא עקב העובדה שתמריצים מסוג זה (הפונים למטפלים עצמם) אינם נפוצים. היעדר תמריצים מסוג זה אינו מעיד בהכרח על חוסר יעילות במבנה התמריץ אלא נובע בעיקר משום שזוהי גישת תמרוץ חדשנית.

סקירת ספרות

השפעת תמריצים כלכליים על תקופת אשפוז



ממצאים ותובנות עיקריות



תמריצים כספיים לקיצור הטיפול ב Nursing Homes והעברת המטופל לטיפול ביתי פועלים גם על הספקים וגם על המטופלים, אבל הם יותר אפקטיביים כאשר הם מיועדים לתמרץ את הספקים.

כשהספק (המטפל) קובע שניתן להמשיך טיפול מהבית, המטופל יבין זאת כהחלטה מקצועית. לעומת זאת, אם יציגו לפניו שיקול כלכלי הוא לא יראה בכך החלטה מקצועית.

יש לדאוג לכך שהתמריץ של הספק לא יגבר על השיקול המקצועי.

Patient VS. Provider Incentives in Long Term Care Martin B. Hackmann



תמצית



החוקרים בדקו את ההשפעה של תמריצים כלכליים על מועד השחרור של מטופלים אשר ביכולתם לקבל את הסיוע הבריאותי בקהילה ולא ב Nursing Homes ובעלי עלות גבוהה יותר. המחקר מצא כי תמריצים כלפי המטופלים הכוללים שיתוף בעלויות יכולים להביא לשחרור מוקדם יותר של מטופלים בעלי מצב בריאותי יציב. יתרה מכך, המחקר מצא כי אשפוז ארוך יותר לא בהכרח תורם לבריאותו של המטופל. על אף זאת, נמצא כי תמריצים המכוונים כלפי הספקים הינם בעלי השפעה גדולה יותר מאשר תמריצים המכוונים לעבר המטופלים.

מבנה השירות



- מערך Medicare הפדרלי הינה תוכנית ביטוח רפואי חברתי אשר זכאים לו אזרחים מעל גיל 65. הביטוח משלם חלק ניכר מהוצאות הבריאות
- Medicaid הינה תוכנית פדרלית/מדינתית אשר מספקת שירותי בריאות לאזרחים בעלי הכנסה נמוכה במיוחד.



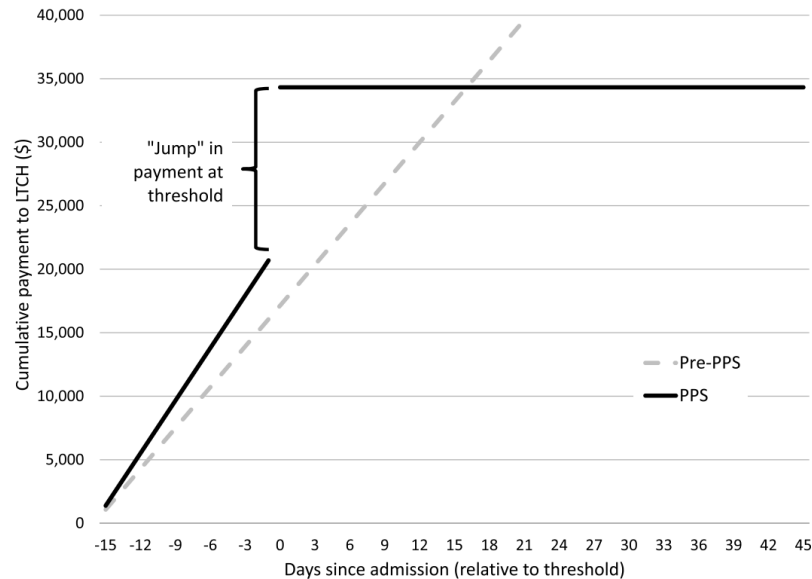
סקירת ספרות

השפעת תמריצים כלכליים על תקופת אשפוז

ממצאים ותובנות עיקריות



ספקי השירות רגישים מאוד לתמריצים עד כדי כך ששיקולים טיפוליים אינם נקבעים רק על ידי מצבו הסיעודי של המטופל אלא ע"י שיקולי רווחיות.



Provider Incentives and Healthcare Costs: Evidence from Long-Term Care Hospitals

Liran Einav and Amy Finkelstein, Neale Mahoney



תמצית



החוקרים בדקו את מדיניות השחרור ממוסד סיעודי לאחר טיפול אקוטי (כלומר לא מדובר בחולים סיעודיים כרוניים). המחקר מתמקד במוסדות סיעודיים המקבלים תשלומים מ Medicare בארה"ב עבור אשפוז זמני של חולים אקוטיים שבהם במנגנון התשלום קיימת רמת סף – כלומר: התשלום ליום אשפוז עולה עד למספר נתון של ימים (לדוגמא 10 ימים) ולאחר מכן התשלום היומי נשאר קבוע. התוצאות מראות ששיעור השחרור ביום הסף חורג בגודלו באופן קיצוני מהימים האחרים וההסבר היחיד לכך הוא שיקול כספי שולט בהחלטות על יום השחרור.

מבנה השירות



- במנגנון התשלום קיימת רמת סף – כלומר: התשלום ליום אשפוז עולה עד למספר נתון של ימים (לדוגמא 10 ימים) ולאחר מכן התשלום היומי נשאר קבוע.

סקירת ספרות

השפעת אינטרסים כלכליים ופוליטיים



ממצאים ותובנות עיקריות



מספר גורמים אשר משפיעים על החלטת המדינה על השתתפות ברפורמת BIP של הממשל הפדרלי:

- אחוז דמוקרטים בשירות המדינה
- אחוז קטן של עובדי מדינה לנפש
- כמות מעטה יחסית של סוכנויות סיעודיות (חברות סיעוד)
- הוצאות יחסית קטנות בתוכניות אלטרנטיביות

חשוב לקחת גורמים אלו בחשבון כאשר מעוניינים לעודד השקעה באוכלוסייה סיעודית.

Federal Incentives to Reform Long-Term Care Under the Affordable Care Act: State Adoption of the Balancing Incentive Program, 2011–2014

Lisa K. Beauregard, and Edward Alan Miller



תמצית



המאמר מבקש לעמוד על המאפיינים השונים אשר הביאו מדינות בארה"ב להצטרף למיזם הפדרלי BIP אשר מטרתו חיזוק הטיפול הקהילתי והמקומי בזקנים ואנשים סיעודיים וזאת על פני אשפוז במוסדות שונים. החוקרים הראו כי מאפיינים כגון מפלגה שולטת, אחוז אוכלוסייה מבוגרת, כמות חברות העוסקות במתן שירותי רפואה סיעוד בייתיים, כמות "בתי אבות", מצב כלכלי כללי של המדינה ועוד הינם גורמי השפעה על כמות ההשקעה בסייעוד. ע"י הבנת גורמים אלו ניתן לתמרץ מדינות לעבר השקעה יתרה בשירותי הסייעוד.

מבנה השירות



- מערך Medicare הפדרלי הינה תוכנית ביטוח רפואי חברתי אשר זכאים לו אזרחים מעל גיל 65. הביטוח משלם חלק ניכר מהוצאות הבריאות
- Medicaid הינה תוכנית פדרלית/מדינתית אשר מספקת שירותי בריאות לאזרחים בעלי הכנסה נמוכה במיוחד.

סקירת ספרות

השפעת פרסום מדידה על חברות הסיעוד



ממצאים ותובנות עיקריות



הדירוגים מעודדים תחרות אפילו אם המטופלים אינם מודעים אליהם מספיק. (חשיפה יותר אינטנסיבית של המטופלים ומשפחותיהם לדירוגים תגדיל את התחרות אף יותר).

כדי שההשפעה תחלחל להטבת הטיפול יש לנסות להגדיל את היצע המטפלות ולאפשר גמישות גדולה יותר במבנה התשלומים.

בעיית גיוס העובדים גוברת כאשר הממשלה מקבעת את השכר ומקשה על גיוס עובדים תחרותי.

Incentives and Deterrents to the Supply of Long-term Care for the Elderly in England: Evidence and Experience in Two Local Authorities

Stephen Allan and Robin Darton



תמצית



המאמר בוחן את היבט ההיצע של שירותי הסיעוד בשתי רשויות מקומיות באנגליה, Bristol ו-Kent. במאמר בוחנים הן את היחס של ה'צרכנים' לדירוג המוסדות הסיעודיים או ליכולת לבחור בין ספקי שירות שונים. כמו כן בוחן המאמר את בעיית גיוס ושימור העובדים אשר הופכת ליותר ויותר קשה. החוקרים מתריעים על הבעיה בקיבוע השכר למטפלים בחוק, דבר המקשה על התאמה לשוק תחרותי ועל שימור עובדים כאשר יכולים להרוויח יותר במקומות אחרים.

מבנה השירות



- שירותי הסיעוד הציבוריים באנגליה ממומנים ברובם ע"י הרשויות המקומיות, אשר מעסיקות חברות פרטיות או ארגונים ללא מטרות רווח עבור אספקת השירותים.



סקירת ספרות

הסבת עלויות - Cost Shifting

ממצאים ותובנות עיקריות



המטפלים וחברות הסיעוד (נותני השירות) הינם גמישים יותר לתמריצים כלכליים ויגיבו בצורה חזקה יותר מאשר המטופלים עצמם

מנגנון המערב מספר גופים המעניקים טיפולים בעלי אופי שונה בהתאם למצב המטופל, יוצרים תמריץ אדיר לכל גוף להעביר את העלויות (כלומר את המטופל) לגוף האחר

מינוי Case Manager יכול להיות משמעותי לשיפור הטיפול במטופל.

Medicare and Medicaid: Conflicting Incentives for Long-Term Care

David C. Grabowski



תמצית



המאמר בוחן את המשמעויות וההשלכות של חפיפת האחריות הטיפולית של שני גופי בריאות בארה"ב על מטופלים גריאטריים. האחריות המשותפת של שני הגופים, ה Medicare הפדרלי וה Medicaid המדינתי מביאה לתמריצים שליליים בטיפול בחולים עצמם, בעיקר בעקבות האפשרות ל Cost Shifting.

מבנה השירות



- מערך ה Medicare הפדרלי הינה תוכנית ביטוח רפואי חברתי אשר זכאים לו אזרחים מעל גיל 65. הביטוח משלם חלק ניכר מהוצאות הבריאות
- Medicaid הינה תוכנית פדרלית/מדינתית אשר מספקת שירותי בריאות לאזרחים בעלי הכנסה נמוכה במיוחד.



סקירת ספרות

הסבת עלויות - Cost Shifting

ממצאים ותובנות עיקריות



הגופים המציעים טיפול בקהילה מעודדים מטופלים להגיש בקשות לטיפול מלא כדי להתנער מהוצאות

אפשרות להסבת עלויות פוגעת באיכות הטיפול ובאחריות אותה מגלים נותני השירותים

The 2015 long-term care reform in the Netherlands: Getting the financial incentives right?

Peter Alders, Frederik T. Schut



תמצית



המאמר בוחן את ההשלכות של הרפורמה בשירותי הסיעוד אשר בוצעה בהולנד בשנת 2015. במאמר מציגים החוקרים את מערך התמריצים ומראים כיצד החלוקה בין הגופים השונים הביאה לאפשרות של הסטת עלויות. אפשרות זו מביאה לפגיעה בטיפול שמקבלים המטופלים הקשים בכל רמה היות וניתן 'לדרדר' אותם לאחריות של גוף אחר בכל פעם.

כמו כן, המאמר מראה כי אין שיתוף פעולה בין הגופים, כך שאין "קייס מנג'ר" אחד אשר מרכז את הטיפול.

מבנה השירות



- שלושה גורמים אשר מקבלים אחריות על מטופלים ברמות שונות.
- רשויות מקומיות וביטוחים פרטיים אחראים על טיפול בקהילה, והמדינה אחראית על טיפול כולל לסיעודיים קשים שזקוקים להשגחה 24/7.



סקירת ספרות

הסבת עלויות - Cost Shifting

ממצאים ותובנות עיקריות



שכיחות הטיפול הקהילתי מושפע יותר על ידי המצב הכלכלי של הרשות מאשר ממצבו הכלכלי של המטופל. כלומר, ישנו cost shifting משמעותי מהראשות המקומית לעבר המדינה

בשיטת המימון הסיעודי בנורבגיה שיקולים רפואיים וסיעודיים עלולים להיות מושפעים מהמצב הפיננסי של רשויות מקומיות ובכך לייצר אי שוויון גאוגרפי באיכות הטיפול

The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway

Henning Øien, Martin Karlsson , and Tor Iversen



תמצית



מטרת המאמר הינה לבדוק האם המבנה הכלכלי של מערכת הסיעוד בנורבגיה מעודד חוסר יעילות או מעורר השלכות בלתי צפויות. במערכת זו הרשות המקומית אמורה לטפל בעצמה באמצעות שירותי טיפול ביתיים, או (במקרים מסוימים) להפנות לאשפוז מלא הממומן ע"י המדינה עצמה. במאמר נמצא כי ההחלטה על אופי הטיפול לא נקבעה על בסיס ההכנסה של המטופל (אשר משפיעה על אחוז המימון העצמי של הטיפול), אלא ע"י ההכנסה הפנויה של הרשות המקומית. כלומר, היכולת של המטופל לכסות את הטיפול לא משפיעה על ההחלטה.

מבנה השירות



- מערך המבוסס על שיתוף בין הרשות המקומית (אשר אחראית על הטיפול הביתי והקהילתי) ובין הממשלה אשר אחראית על הטיפול המלא (24 ש') או אשפוז במוסדות ובתי חולים.
- כמו כן, המטופל משלם חלקית על הוצאות הטיפול באחוזים שונים ע"פ אופי הטיפול ורמת ההכנסה

סקירת ספרות – סיכום ותובנות



כדי לעבור לטיפול חסכוני יותר המטופל ידרוש לדעת שהטיפול החליפי ייטיב את מצבו הבריאותי ולא רק את מצבו הכלכלי.

(שקף 63)



תמריצים כלכליים הינם יעילים גם על ספקים וגם על מטופלים אך הם אפקטיביים יותר כאשר הם פועלים על הספקים.

(שקף 63)



ככל שהיצע המטפלות יגדל, כך תגדל האפקטיביות של השיטות השונות להגברת התחרות בין חברות הסיעוד

(שקף 66)



כדי לייצר תחרות בין הספקים יש לערוך דירוגים מבוססי נתונים וכן מנגנון שיפיץ אינפורמציה זו בציבור.

(שקף 66)

סקירת ספרות – סיכום ותובנות



**זהירות רבה בריבוי רשויות האחראיות על
סוגים שונים של טיפולים בהתאם למצב
המטופל בשל אפשרות ל Cost Shifting -
נפילה בין הכיסאות.**

(שקפים 67,68,69)



**בתכנון מערכת תמריצים יש לקחת בחשבון
את הנכונות של השחקנים השונים לשתף
איתה פעולה.**

(שקף 65)



**צריך להקפיד שהתמריצים הכלכליים עבור
הספקים לא יגברו על השיקול המקצועי.**

(שקף 64)

סיכום תובנות עיקריות

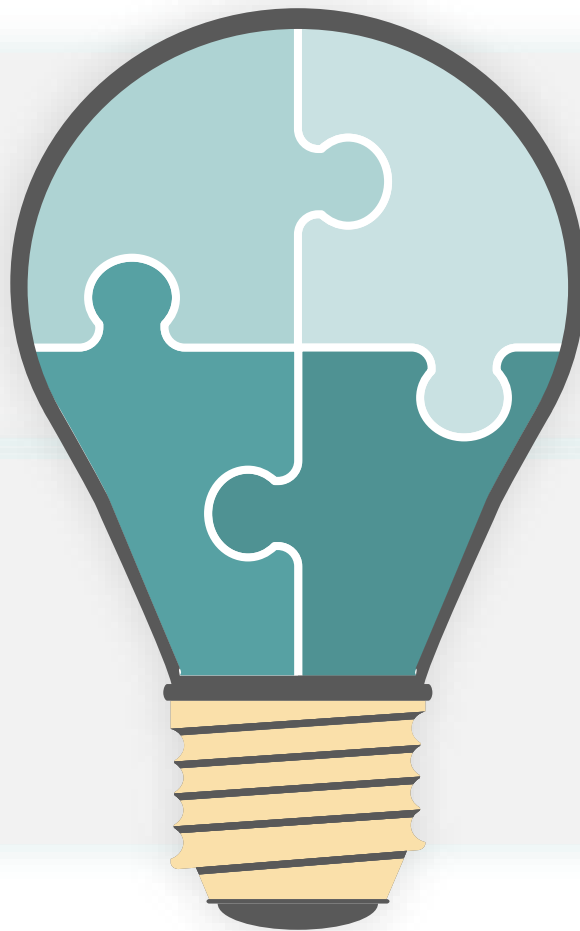
כינוס תובנות עיקריות להמשך הדיון

מקרי מבחן מישראל

מיפוי המצב הקיים

סקירת ספרות

סקירה בינלאומית



תובנות עיקריות ממיפוי המצב הקיים

בני משפחה



- ◀ מעבר להיותם גורם חשוב המטפל במקבלי השירות גם ללא תפקיד רשמי, **בני משפחה מטפלים הופכים לאחוז הולך וגדל מכלל המטפלים**. דבר זה מצריך היערכות, הכשרות מותאמות והכוונה המותאמת אישית לאוכלוסייה זו.
- ◀ **שיפור הידע של בני המשפחה** בתחומי הטיפול יכול לשפר את מצב מקבל השירות, את הכוונת מטפלות לטיפול דוחק תלות ואת שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים למימוש זכויותיו מקבל השירות בצורה היעילה ביותר.

מקבלי השירות



- ◀ **מקבלי השירות הינם לרוב אוכלוסייה מוחלשת**, דבר המייצר כשל שוק ועלול לפגוע בתמריצים להתייעלות ולשיפור השירות ללקוחות הקיימים ולמטפלות המועסקות.
- ◀ חלק ממקבלי השירות נוטים **להעדיף סיוע בביצוע פעולות שאינן בהכרח יעילות לדחיקת תלות**.

מטפלות.ים



- ◀ עקב התשלום השעתי הקבוע, **לא קיימים תמריצים למטפלות לעבור הכשרות** דבר הפוגע בשיפור השירות והשפעתו על דחיקת תלות.
- ◀ למטפלות **אין אופק קידום** והתפתחות, דבר המייצר תמריץ שלילי לשיפור השירות ולהתמקצעות וכן תורם לנטישת הענף.
- ◀ תמריצים כלכליים על חברות הסיעוד עשויים **לחלחל מטה למטפלות.ים באופן חלקי בלבד**.

חברות סיעוד



- ◀ **מדדי תוצאה שיוגדרו בצורה שאינה מיטבית יכולים להביא לתוצאות הפוכות** מהרצוי או לייצר הטיה במתן הטיפול (עקב העדפה של מטופלים קלים לאור סיכויי השיפור/שימור הגבוהים יותר).
- ◀ **יש מיעוט מעברים של מטופלים בין חברות** לאחר תחילת הטיפול ושל מטפלות לאחר תחילת ההעסקה, דבר אשר יוצר חוסר בתמריצים להתייעלות ולשיפור השירות ללקוחות מחד, ובתנאים של המטפלות מאידך.

תובנות עיקריות ממקרי המבחן בישראל



בני משפחה



מטופלים



מטפלות.ים



חברות סיעוד

בבסיס כל תמריץ עומדת יכולת מדידה של השירות הניתן. ללא מדידה לא יתכן תמרוץ ותגמול על תפקוד מיטבי. פרסום של המדידה לציבור מסייע בשקיפות, בבחירה מיטבית של הספק וכתוצאה מכך לשיפור השירות.

קביעת תוכנית אישית ומדידת הספק ביחס לעמידה ביעדיה מסייעת למקצע את הטיפול ולייצר מומחיות.

כללי



ניתן לייצר מכרז המאפשר גמישות למשרד לשינויים עתידיים. מתוך הבנה כי יתכנו שינויים והתפתחויות בתחום יש לייצר מכרז המאפשר גמישות למשרד בקביעת מדדים, מדידות ותמריצים חדשים לאורך חיי ההתקשרות.

הכשרות משולמות back to back לעובדים ע"י המשרד, ורק עוברות דרך הספק. כך ניתן לתמרץ ישירות את אופי וכמות ההכשרות אשר עוברים העובדים.

התאמת המטפלת למטופל משפרת את איכות השירות והשפעתו על המטופל.

אפשרות לשוונות בשכר העובדים כחלק מהמכרז עצמו יכולה לאפשר לספק לייצר דיפרנציאציה בשכר לצורך שימור ותגמול עובדים.

מודל המספק שירות שבבסיסו תשומות, יכול להתבסס על תמרוץ באמצעות בונוסים מבוססי תפוקות או תוצאות אשר נועדו לייצר השקעה נוספת ע"י הספק ושיפור השירות בנקודות מפתח.

ניתן לבצע חלק מהמדידה באמצעות הספק עצמו תוך השלמת בקרה ומדידה מצד המדינה.

תובנות עיקריות מהסקירה הבינלאומית



בני משפחה

ללא התייחסות <



מקבלי השירות

< **מקבל השירות הוא הגורם המסוגל להגדיר בצורה המיטבית מהו השירות הרצוי עבורו ומהן תוצאותיו הרצויות**

< **מבחן הכנסה מסייע בניהול ביקושים, אך נדרש לנהל אותו ברזולוציה גבוהה**

< **בבחינת התמריצים הכלכליים יש לתת ביטוי לכשלי השוק המובנים בתחום הסיעוד**



מטפלות.ים

ללא התייחסות <



חברות סיעוד

< **הגדרת מדדי תוצאה מאפשרת גמישות וחדשנות בקרב חברות הסיעוד ומייצרת תמריץ לשיפור השירות**

< **תמריצים להתייעלות כלכלית, עשויים להשפיע באופן שלילי בכיוון אחר ולכן נדרשת בחינה רב ממדית**

תובנות עיקריות מסקירת הספרות



ללא התייחסות <



< פעמים רבות נוצר מצב בו אין **Case Manager** ברור למטופל, דבר הפוגע באיכות הטיפול אשר מקבל מקבלי השירות.

< **מעורבות גדולה יותר של מקבלי השירות** (או בני משפחתו) בבחירת הטיפול וטיבו וכן השתתפות עצמית קטנה בעלויות יכולים לטייב את אופי הטיפול ולמנוע מצב של הסבת עלויות והסטת אחריות



< **פער בתמריצים כלליים** המופנים כלפי המטפלים עשוי להוביל לנטישת הענף ופגיעה בכח העבודה בתחום



< **חפיפה בתחומי אחריות של גופים שונים על מצב מקבלי השירות** עלולה להוביל לפגיעה באיכות הטיפול או להעברת מקבלי השירות בין הגופים השונים.

< **חברות הסיעוד הינן גמישות יותר לתמריצים כלכליים** מאשר מקבלי השירות עצמם. כלומר, תמריץ כלכלי יביא לשינוי משמעותי יותר בהתנהגות הספק מאשר בהתנהגות מקבלי השירות.

< **תקצוב לא מדויק של השירות יכול להביא לפגיעה ביכולת הספקים להשיג כמות עובדים** מספקת ובשימורם בענף

ניתוח תמריצים הפועלים במדידה בתפוקות

עיקרי התמריץ:

הגדרה יעדים של תפוקות אשר נדרש מהמטפל לבצע כחלק מהשירות הניתן למטופל או מאפיינים שהמטפל/חברת הסיעוד נמדדים על פיהם, וקבלת תגמול בהתאם לעמידה/אי-עמידה ביעדים אלו.

דוגמאות:

- הגדרה של כמות פעמים של יציאה מהבית עם מקבל השירות
- הגדרה של פעולות אשר המטפל נדרש לעשות יחד עם המטפל
- הגעה למרכזי יום
- שיעור המטפלות.ים בעלי ההכשרה

יתרונות

- ◀ מאפשר לעודד פעולות אשר אמורות לשפר/לשמר את מצב מקבל השירות. ע"י הגדרת תפוקות ברורות ניתן להציב **סט של פעולות אשר נקבעו כי יביאו לדחיקת תלות** ושיפור איכות חייב ובריאותו של המטופל, ולהביא את כלל המטפלים והחברות לפעול על פי סט פעולות זה.
- ◀ תגמול מבוסס על פעולות שנעשו ע"י המטפל מקדם באופן ממוקד את התפוקה. מאפיין זה יוצר **תמריץ חזק ביותר לביצוע הפעולות** אשר הוגדרו כמיטיבות עם המטופל.
- ◀ מחייב ידע ומקצועיות של המטפלות.ים בפעולות הרצויות, דבר אשר **יחייב הכשרות מתאימות** ושיפור המקצועיות.

חסרונות

- ◀ דורש **ניהול מעקב ומדידה** אחר עמידה בתפוקות הרצויות
- ◀ **אתגר בהגדרת התפוקות** הרצויות אשר ישיגו את התוצאות הרצויות ויביאו לשיפור מצב המטופל או לשימורו.
- ◀ **שוני רב בין מטופלים** גוזר תפוקות שונות אשר רצויות לכל מטופל. אי לכך, ישנה מורכבות בקביעת יעדי תפוקות מוגדרים לכלל האוכלוסייה.
- ◀ לא כולל בחינה של התוצאות ולכן **לא מאפשר בחינה של הצלחת התמריצים** בהשגת היעד של דחיקת התלות

ניתוח תמריצים הפועלים במידה בתוצאות

עיקרי התמריץ:

תימרוץ על בסיס השגת תוצאות מסוימות אשר נמצאות בהלימה עם היעד של דחיקת התלות

דוגמאות:

- מבחן תפקוד אשר בודק את מצבו של מקבל השירות ובחינת קצב ההידרדרות בהסתכלות רחבה
- היקף ימי אשפוז של מטופלים

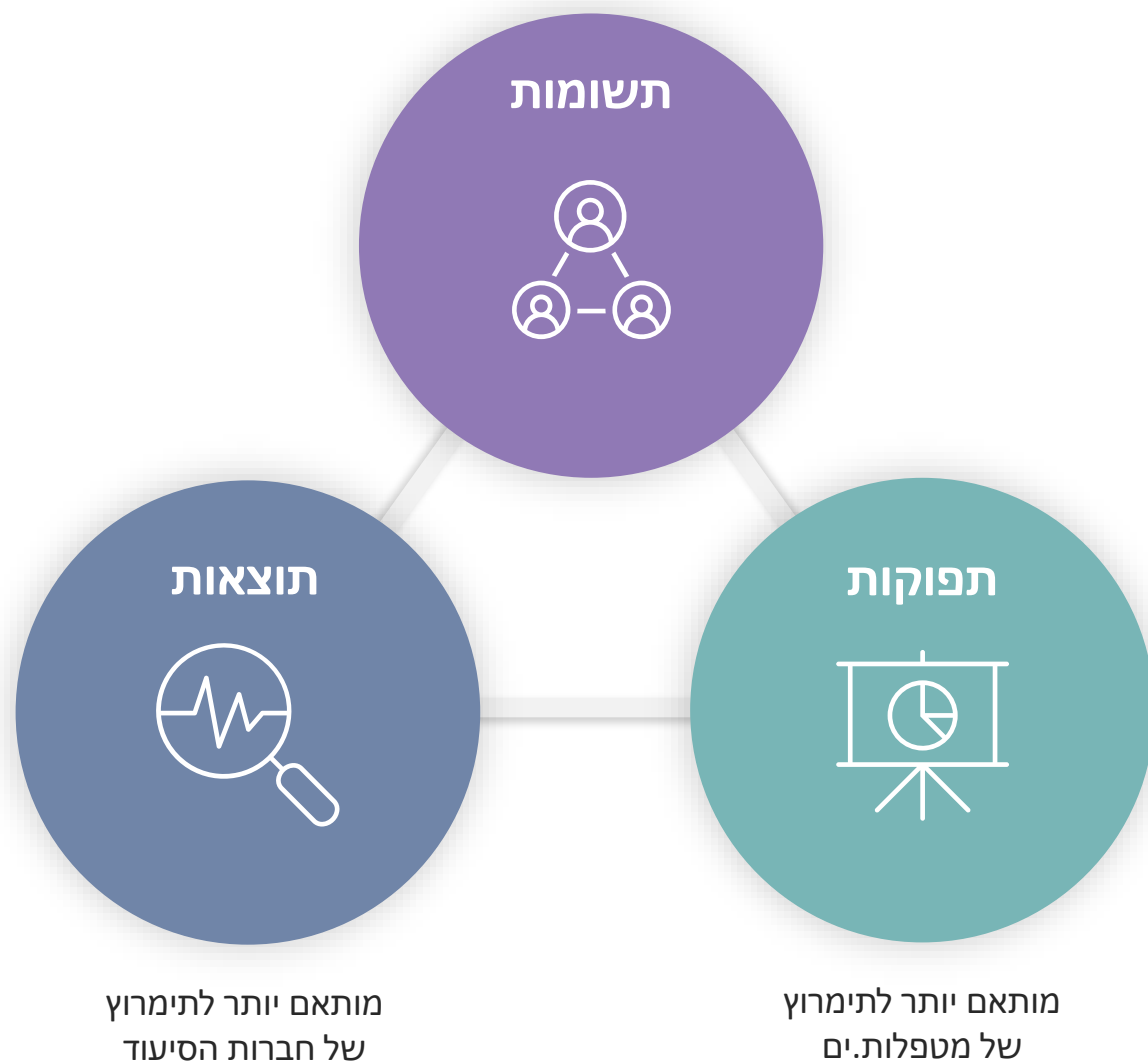
יתרונות

- « מתמרץ באופן ישיר את התוצאה הרצויה בפועל
- « מדדי תוצאה מאפשרים **חופש פעולה יחסי לנותני השירות** ביחס לאופי השירות הניתן – מגוון אפשרויות בדרך למטרה
- « מדדי תוצאה מעודדים **חדשנות ויצירתיות** של נותני השירות
- « מעודד את **שיפור השירות** והשקעה במצבו הבריאותי של מקבל השירות

חסרונות

- « גורמים רבים המשפיעים על מצבו הבריאותי של מקבל השירות מביאים לקושי רב במדידה מדויקת של השפעת השירות ולצייר הטיה בבחינה
- « מערך מדידה נלווה מורכב יותר הנדרש לטובת המהלך
- « עלול לעודד בחירה סלקטיבית של מטופלים בעלי אופק שימור תפקוד ע"י חברות הסיעוד
- « מדדי תוצאה עשויים להיות **מוטים למניפולציות** של המתומרצים

תובנה מסדרת מהשלב הראשון בפרויקט:



מנגנון תמריצים אשר משלב בתוכו תשומות, תפוקות ותוצאות יוכל לצמצם את השפעות המשנה של התמריצים תוך שמירה על מערכת מאוזנת המקדמת את יעדי דחיקת התלות

תובנות נוספות לגבי מדידת תמריצים



לא ניתן לייצר מדדים ללא מדידה של השירות

על מנת לייצר תמריצים אשר יעודדו התנהגות מסוימת יש צורך במדידה של השירות המוענק למטופל.



פרסום מדדים על חברות הסיעוד מחזק את התחרות בענף

עצם מדידת החברות ופרסום המדדים מחזק את התחרות בענף. גם בהתחשב בעובדה כי הנגישות למידע בקרב קהל היעד מוגבלת. ניתן לראות כי במדינות אחרות ישנן דרכים ייעודיות לפרסום המדדים לאוכלוסיית היעד.



מדידת תוצאות באמצעות ממוצעים בדגימה רחבה מוטה פחות להשפעות חיצוניות

לאור היקף הזכאים, עבור חברות הסיעוד ניתן לייצר מדידים כמותיים ע"ב סטטיסטיקה של אוכלוסיית מקבלי השירות כולה. מדידה זו עדיפה מכיוון שמצבו של כל מטופל בודד יכול להיות מושפע בקלות מגורמים רבים שאינם קשורים כלל בטיפול שקיבל

תובנות נוספות לגבי השפעת התמריצים על בעלי העניין השונים



ישנה עדיפות לתמריצים אשר יופעלו ישירות על המטפלות.

נראה כי נכון לשלב תמריצים לשיפור הטיפול אשר יפעלו ישירות על המטפלות עצמן לאור חשש מחילחול חלקי של התמריצים מחברות הסיעוד. תמריצים אלה יכולים לעבור הן בתשלום ישיר והן בתשלום Back-to-Back דרך החברות.



תמריצים כלכליים משפיעים בצורה חזקה על נותני השירות

מסקירת מחקרים וכן משיחות עם בעלי העניין ניכר כי תמריצים כלכליים משפיעים בצורה חזקה על התנהגות נותני השירות. לעומת זאת, המחקרים מראים כי תמריצים אלו משפיעים פחות על התנהגות מקבלי השירות.



נותני השירות



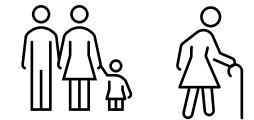
נדרשת בחינת אפשרויות שונות לניהול החלק הכספי של הגמלה

מהסקירות שנעשו ניכר כי ישנם מנגנונים שונים לניהול כספי הגמלה כך שיופנו לעבר טיפול מיטבי בקשיש/מטופל וימנעו הסבת התקציב לשימושים אחרים.



קריטריון של רמת תפקוד אינו מתאים בהכרח לחלוקה של כסף מול שעות

רמת התפקוד אינה מעידה הקריטריון הנכון לקביעת הרכב הגמלה. ייתכן ויש צורך לאפיין קריטריון אחר אשר יוכל לעזור בהגדרת הרכב הגמלה הרצוי לכל סוג מטופל.



מוטבי השירות



יש לבחון את נוחות המעבר בין החברות ולהקל על התהליך

על מנת לאפשר שוק כמה שיותר חופשי ולעודד תחרות יש לחשוב על מנגנון אשר יאפשר התניידות מהירה, קלה ופשוטה ביותר בין החברות השונות. כך יתאפשר למטופלים לבחור ולעבור בין חברות ביתר קלות



יש לשקול ביצוע שינוי הדרגתי של המנגנון בכמה פעימות

לאור ההשפעות מרחיקות הלכת של השינויים המוצעים, וכן לאור העובדה כי ישנן השפעות שלא יהיה ניתן לצפות מראש, יש צורך לחשוב על מודל אשר יאפשר שינוי הדרגתי של מנגנון ההפעלה

הצעה למודל להערכת תמריצים בשלב הבא

1. פרמטרים למודל
2. המודל המוצע

מודל להערכת תמריצים קטגוריות מבחן

המודל מציע 9 קטגוריות לבחינה של מערכי תמריצים בצורות שירות שונות אשר יוצעו בשלבים הבאים לעבודה.

המודל מבקש להציב קטגוריות מובחנות אשר באמצעותן יהיה ניתן לבחון חלופות שונות למערכי תמריצים.

מקצועיות



רמת המקצועיות אשר מעודד מבנה השירות של המודל

יעילות תקציבית



יעילות השימוש בסך התקציב לגמלת הסיעוד

טיפול מותאם אישית



עד כמה מכווין מבנה שירות טיפול מותאם אישית

ניצול הגמלה לטיפול יעיל



עד כמה תקציב הגמלה ממוצה על טיפול ישיר למטופל ומונע שימוש למטרות אחרות

ישימות



עד כמה המודל המוצע ישים?

שימור האינטרסים הקיימים של בעלי העניין



שימור רמת האינטרסים הקיים של כלל בעלי העניין

מורכבות מערכים תומכים



כמה מערכים תומכים נדרש להקים על מנת לתמוך במודל ורמת מורכבותם (טכנית וכספית)

נגישות הטיפול



נגישות הטיפול לכלל האוכלוסייה במודל המוצע

מיקוד השירות בדחיקת תלות

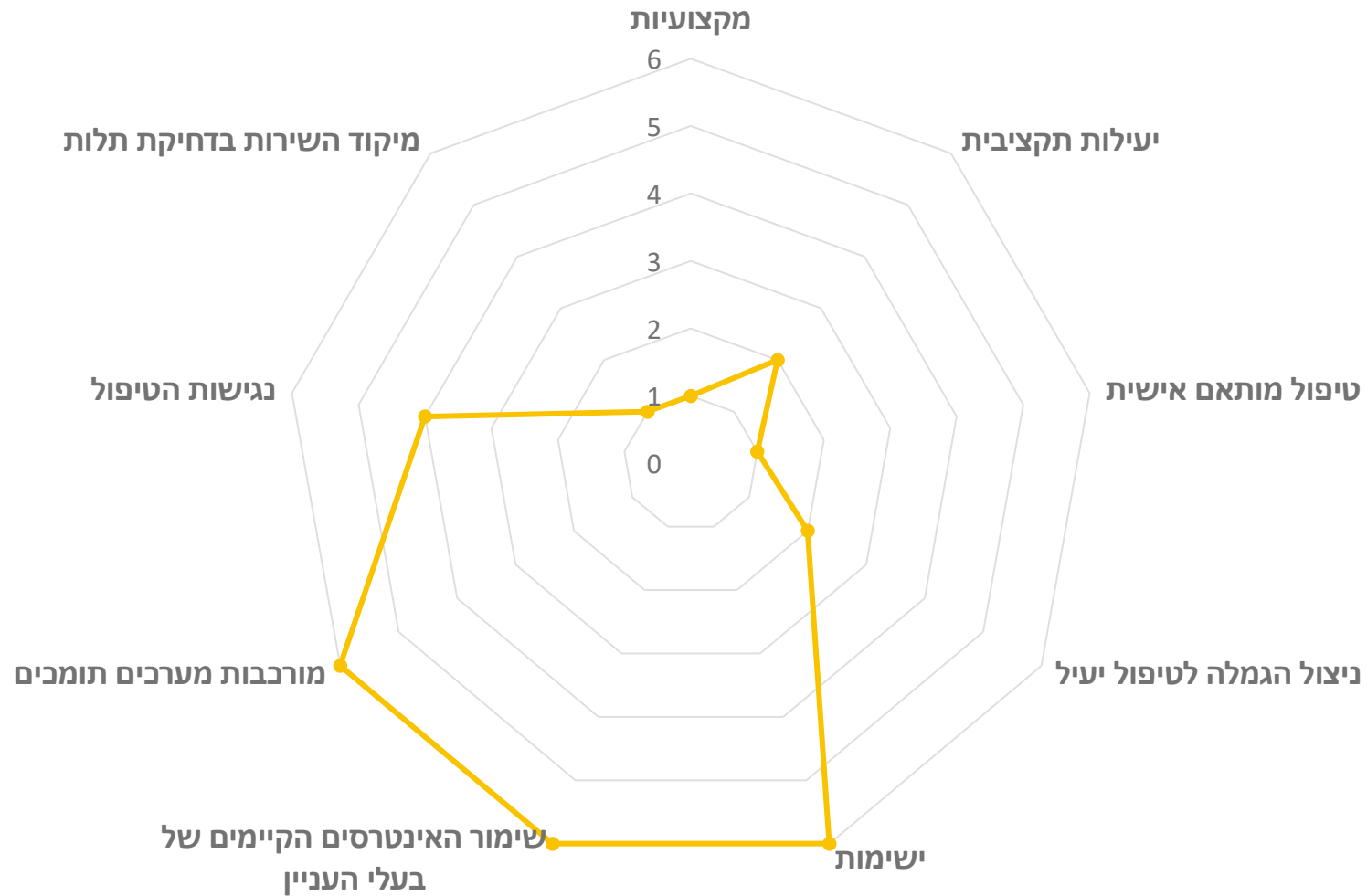


רמת ההכוונה של השירות לעבר טיפול דוחק תלות

מודל להערכת תמריצים

מאפייני המודל הקיים

מבנה הגמלה הנוכחי כפי שהוא
מנותח ע"פ כל פרמטר שהוצג
בשקף הקודם



מקרא:

מודל נוכחי

תודה רבה

סקירת ספרות - ביבליוגרפיה

- Alders, Peter, and Frederik T. Schut. "[The 2015 long-term care reform in the Netherlands: Getting the financial incentives right?](#)" *Health Policy* 123.3 (2019): 312-316.
- Beauregard, L. K., and E. A. Miller. "[Federal Incentives to Reform Long-Term Care under the Affordable Care Act: State Adoption of the Balancing Incentive Program, 2011-2014.](#)" *The Journals of gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences* (2021).
- David C. Grabowski, 2007. "[Medicare and Medicaid: Conflicting Incentives for Long-Term Car](#)", The Milbank Quarterly, Vol. 85, pp. 579–610.
- Hackmann, Martin B., and R. Vincent Pohl. "[Patient vs. provider incentives in long term care](#)". No. w25178. National Bureau of Economic Research, 2018.
- Liran Einav and Amy Finkelstein, (2018) "Neale Mahoney, Provider Incentives and Healthcare Costs: Evidence from Long-Term Care Hospitals", *Econometrica* VOLUME 86, ISSUE 6
- Stephen Allan, and Robin Darton, 2021. "[Incentives and Deterrents to the Supply of Long-term Care for the Elderly in England: Evidence and Experience in Two Local Authorities](#)", *Social Policy and Society* , Volume 21, pp. 304 – 315
- Øien, Henning, Martin Karlsson, and Tor Iversen. "[The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway.](#)" *Applied economic perspectives and policy* 34.2 (2012): 258-274.

מקורות מידע לסקירה הבינלאומית:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851018305980?via%3Dihub>

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332759/Eurohealth-21-3-47-50-eng.pdf;sequence=1>

<https://english.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl-eng/documents/publications/2016/01/31/healthcare-in-the-netherlands/healthcare+in+the+netherlands.pdf>

<https://www.ciz.nl/client/eigen-bijdrage>

<https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/wlz-pgb>

<https://english.scp.nl/publications/publications/2017/02/24/the-market-for-domiciliary-care>

https://feb.studenttheses.ub.rug.nl/16935/1/Scriptie_s2239000.pdf

<https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/netherlands>

<https://oecd-opsi.org/innovations/a-new-social-support-model-performance-based-funding-under-the-social-support-act/>

<https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/dewmo2015inpraktijk-januari2018.pdf>

<https://rm.coe.int/168059945c>

https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2021-03/final-report-volume-2_0.pdf

<https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/08/ninth-report-on-the-funding-and-financing-of-the-aged-care-industry-july-2021.pdf>

<https://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-government-services/2022/community-services/aged-care-services>

https://www.gen-agedcaredata.gov.au/www_ahwgen/media/ROACA/21520-Health_Report-on-the-Operation-of-the-Aged-Care-Act-2020%e2%80%932021.pdf